Definición de la Arquitectura de Negocio del Hospital de Tingo María: Arquitectura Base y Objetivo para la Atención en Consulta Externa

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	05/11/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial como Documento de Definición de la Arquitectura de Negocio (versión 1.0 del dominio): validación de metas, objetivos, impulsores y principios; arquitectura de negocio base y objetivo; desarrollo de los escenarios EB-02 y EB-03; análisis de brechas; evaluación de impacto; arquitectura de transición; componentes candidatos del Plan de Itinerario y evaluación de actualización de la Declaración de Trabajo (A-02).

Nota. Este documento eleva a la versión 1.0 la arquitectura de negocio que A-05 entregó en versión 0.1. Las arquitecturas de datos, aplicaciones y tecnología continúan en versión 0.1 hasta el cierre de las Fases C y D (A-02, Tabla 18).

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Documento de Definición de la Arquitectura (*Architecture Definition Document*), dominio de negocio
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión del documento	1.0 (borrador para aprobación del ARB)
Versión de la arquitectura	Negocio 1.0
Fecha de la versión	05/11/2026
Revisado por	Architecture Review Board (ARB)
Fecha prevista de revisión	Sesión del ARB de la semana 12 (Hito H2)
Próximas versiones	Datos y aplicaciones 1.0 (semana 15, C-01 y C-02); tecnología 1.0 (semana 16, TEC-01)
Documentos de los que depende	A-01 v2.1; A-02 v2.1; A-03; A-04; A-05 v2.1; Guía de bolsillo de TOGAF 9.1 (Josey, 2011)

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Architecture Review Board (ARB)	Revisar y aprobar	Semana 12	Sesión del ARB
Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Aprobar y firmar	Semana 12	Sesión del ARB y documento firmado
Dirección Asistencial y jefaturas médicas	Validar procesos y escenarios	Semana 11	Taller de validación
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Validar metas, objetivos e indicadores	Semana 11	Correo institucional
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Revisar impactos y dependencias	Semana 11	Sesión de trabajo
Oficina de Recursos Humanos	Revisar impactos en roles y capacitación	Semana 11	Correo institucional
Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco	Informar	Semana 12	Oficio institucional

Resumen

Este documento presenta la arquitectura de negocio del Hospital de Tingo María para la primera iteración del ciclo ADM de TOGAF 9.1, centrada en la cadena de atención de consulta externa. Su propósito es convertir la visión aprobada en la Fase A en una definición verificable del negocio: qué se quiere lograr, qué principios lo gobiernan, cómo se atiende hoy al paciente, cómo se quiere atender en el horizonte de 24 meses y qué brechas, impactos y componentes de hoja de ruta se derivan de ese cambio.

La arquitectura base muestra un negocio organizado alrededor de los servicios y no del paciente: el paciente repite trámites en admisión, laboratorio y farmacia; la historia clínica está dispersa entre papel y registros digitales aislados; los tiempos de espera no se miden; y los indicadores estratégicos se consolidan manualmente. La arquitectura objetivo reorganiza la cadena de valor alrededor del paciente, con una sola admisión, identificación única, órdenes y resultados en línea, prescripción electrónica, registro automático de la prestación y seguimiento de indicadores. El cambio se apoya en los ocho principios de arquitectura confirmados (PA-01 a PA-08), en cinco principios de negocio (PN-01 a PN-05) y en los ocho bloques de construcción de arquitectura (BB-01 a BB-08) definidos en la Fase A.

Las brechas de negocio se agrupan en personas, procesos, herramientas, información, medición, financiamiento e instalaciones. Las de mayor prioridad son la fragmentación de la información clínica (BR-02), la ausencia de una función de gobierno de la arquitectura (BR-05), la falta de inventario (BR-06) y la vigencia no confirmada del instrumento de planificación (BR-08). La evaluación concluye que no se requieren

cambios de alcance en la Declaración de Trabajo: se emite la versión 2.1 de A-02 solo para registrar el cierre de la Fase B y el estado de las condiciones previas.

Los componentes candidatos del Plan de Itinerario se organizan en diez líneas de negocio, con dependencias explícitas hacia las Fases C, D, E y F. Ninguno de ellos puede implementarse antes de que el ARB apruebe la hoja de ruta y se asegure el financiamiento de la primera etapa.

Palabras clave: arquitectura de negocio, TOGAF 9.1, consulta externa, expediente clínico electrónico, cadena de valor, capacidades, brechas, hoja de ruta.

Contenido

Resumen **2**
Lista de figuras **5**
Lista de tablas **5**
1. Introducción **7**
1.1 Propósito del documento 7
1.2 Correspondencia con las salidas de la Fase B 8
1.3 Entradas y salidas 8
1.4 Relación con los demás entregables 9
1.5 Convenciones de identificadores 9
2. Definición de la arquitectura de negocio **10**
2.1 Alcance 10
2.2 Metas, objetivos y restricciones 11
2.2.1 Metas de negocio 11
2.2.2 Objetivos de arquitectura 13
2.2.3 Motivaciones de negocio 15
2.2.4 Restricciones de negocio 17
2.3 Principios 19
2.3.1 Principios de negocio validados 19
2.3.2 Principios de arquitectura de negocio elaborados 21
2.3.3 Cumplimiento de principios en las decisiones de negocio 24
2.4 Arquitectura de negocio de línea base 24
2.4.1 Cadena de valor del paciente (AS-IS) 24
2.4.2 Capacidades de negocio (AS-IS) 25
2.4.3 Procesos de negocio (AS-IS) 27
2.4.4 Actores y roles (AS-IS) 29

2.4.5 Escenarios de negocio 31
2.5 Arquitectura de negocio objetivo 33
2.5.1 Cadena de valor del paciente (TO-BE) 33
2.5.2 Capacidades de negocio objetivo 34
2.5.3 Procesos de negocio objetivo 36
2.5.4 Actores y roles objetivo 39
2.5.5 Escenarios de negocio desarrollados 41
2.6 Vistas y puntos de vista 45
3. Justificación y enfoque de la arquitectura 47
3.1 Racional de las decisiones de negocio 47
3.2 Enfoque 49
4. Correspondencia con el Repositorio de Arquitectura 49
4.1 Correspondencia con el panorama de arquitectura 49
4.2 Correspondencia con modelos de referencia 50
4.3 Correspondencia con estándares 50
4.4 Evaluación de reutilización 52
5. Análisis de brechas 52
5.1 Brechas de negocio por categoría 52
5.2 Matriz de brechas entre la línea base y el objetivo 54
5.3 Priorización de brechas 56
6. Impacto en el panorama de arquitectura 58
6.1 Impacto en las arquitecturas preexistentes 58
6.2 Cambios recientes que afectan la arquitectura de negocio 58
6.3 Oportunidades 58
6.4 Impacto en otros proyectos 59
7. Arquitectura de transición 59
7.1 Definición de los estados de transición 59
7.2 Arquitectura de negocio por estado de transición 61
7.3 Dependencias de datos, aplicaciones y tecnología por estado 63
8. Componentes candidatos del Plan de Itinerario 65
8.1 Componentes candidatos de la arquitectura de negocio 65
8.2 Catálogo de factores de implementación 67
8.3 Matriz consolidada de brechas, soluciones y dependencias 69
8.4 Recomendaciones de implementación 69
9. Actualización de la Declaración de Trabajo de Arquitectura 70
9.1 Evaluación de la necesidad de actualización 70
9.2 Contenido de la actualización menor 70
9.3 Registro y comunicación 70
10. Supuestos y riesgos de la arquitectura de negocio 71
10.1 Supuestos 71
10.2 Riesgos 73
11. Conclusiones 75
12. Referencias 75
13. Apéndices 76
Apéndice A. Siglas 76

Apéndice B. Matriz de trazabilidad 76
Apéndice C. Actas de validación 78
Apéndice D. Glosario..... 78
Apéndice E. Correspondencia con la plantilla de Architecture Definition 79
14. Hoja de control de aprobaciones..... 79

Lista de figuras

- Figura 1. Mapa de alcance de la arquitectura de negocio
- Figura 2. Cadena de valor del paciente: situación actual (AS-IS)
- Figura 3. Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación actual (AS-IS)
- Figura 4. Cadena de valor del paciente: situación objetivo (TO-BE)
- Figura 5. Capacidades de negocio: nivel actual y objetivo
- Figura 6. Flujo del escenario EB-02: consulta de la historia clínica
- Figura 7. Flujo del escenario EB-03: registro y envío de la prestación al SIS
- Figura 8. Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación objetivo (TO-BE)
- Figura 9. Vista integrada por capas de la arquitectura objetivo
- Figura 10. Secuencia de los estados de transición

Lista de tablas

- Tabla 1. Historial de versiones del documento
- Tabla 2. Datos de seguimiento del entregable
- Tabla 3. Destinatarios del documento y acción esperada
- Tabla 4. Correspondencia entre las salidas de la Fase B y este documento
- Tabla 5. Entradas y salidas del documento
- Tabla 6. Relación de B-01 con los entregables del proyecto
- Tabla 7. Alcance de la arquitectura de negocio
- Tabla 8. Metas de negocio validadas
- Tabla 9. Objetivos de arquitectura validados y criterio SMART
- Tabla 10. Motivaciones de negocio validadas
- Tabla 11. Restricciones que condicionan la arquitectura de negocio
- Tabla 12. Principios de negocio validados
- Tabla 13. Principios de arquitectura elaborados para el dominio de negocio
- Tabla 14. Relación entre principios y decisiones de la arquitectura de negocio

- Tabla 15. Capacidades de negocio en la línea base
- Tabla 16. Procesos de la consulta externa en la línea base
- Tabla 17. Actores y roles de negocio en la línea base
- Tabla 18. Escenarios de negocio y su estado en la Fase B
- Tabla 19. Capacidades de negocio objetivo y su contribución
- Tabla 20. Procesos de la consulta externa en la arquitectura objetivo
- Tabla 21. Cambios en actores y roles
- Tabla 22. Escenario EB-02
- Tabla 23. Escenario EB-03
- Tabla 24. Vistas de negocio elaboradas
- Tabla 25. Decisiones de arquitectura y su efecto en el negocio
- Tabla 26. Ubicación de los contenidos de B-01 en el Repositorio
- Tabla 27. Modelos de referencia utilizados
- Tabla 28. Estándares aplicables a la arquitectura de negocio
- Tabla 29. Elementos reutilizables de la Fase A y su tratamiento
- Tabla 30. Brechas de negocio por categoría
- Tabla 31. Matriz de cambios entre la arquitectura base y la objetivo
- Tabla 32. Priorización de las brechas de negocio
- Tabla 33. Impacto sobre las arquitecturas existentes
- Tabla 34. Cambios recientes y su efecto
- Tabla 35. Oportunidades identificadas
- Tabla 36. Relación con otros proyectos e iniciativas
- Tabla 37. Estados de transición y su contenido de negocio
- Tabla 38. Detalle de negocio por estado de transición
- Tabla 39. Dependencias de los estados de transición con las Fases C, D y E
- Tabla 40. Componentes candidatos del Plan de Itinerario
- Tabla 41. Factores que condicionan la implementación
- Tabla 42. Matriz de brechas, soluciones y dependencias
- Tabla 43. Recomendaciones para las Fases E y F
- Tabla 44. Evaluación de los disparadores de actualización de A-02
- Tabla 45. Cambios incorporados en A-02 v2.1
- Tabla 46. Supuestos de la arquitectura de negocio

- Tabla 47. Riesgos de la arquitectura de negocio
- Tabla 48. Aprobaciones del documento
- Tabla A1. Siglas utilizadas en el documento
- Tabla B1. Trazabilidad entre metas, objetivos, principios, capacidades, procesos, escenarios, requisitos, brechas, bloques y KPI
- Tabla C1. Acta de validación del escenario EB-01
- Tabla C2. Acta de validación del escenario EB-02
- Tabla C3. Acta de validación del escenario EB-03
- Tabla D1. Términos utilizados en el documento
- Tabla E1. Correspondencia entre la plantilla de TOGAF y este documento

---

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este es el Documento de Definición de la Arquitectura (ADD) del dominio de negocio y el entregable principal de la Fase B del ciclo ADM. Describe la arquitectura de negocio base y objetivo del Hospital de Tingo María para la cadena de atención de consulta externa, con el nivel de detalle estratégico y de segmento acordado en la Declaración de Trabajo (A-02, sección 6.2). No es un diseño de soluciones ni un plan de implementación: esas decisiones corresponden a las Fases C a F.

El documento tiene tres propósitos concretos:

1. **Validar el negocio.** Confirmar con la Dirección, las jefaturas médicas y Planeamiento que las metas, objetivos, motivaciones y principios heredados de la Fase A siguen vigentes y son medibles.
2. **Definir el cambio.** Describir cómo se atiende hoy al paciente y cómo se debe atender en el horizonte de 24 meses, con procesos, actores, capacidades y escenarios verificables.
3. **Preparar la transición.** Identificar brechas, impactos, estados de transición y componentes candidatos del Plan de Itinerario, de modo que las Fases C a F trabajen sobre una base de negocio aprobada y trazable.

El documento se complementa con la Especificación de Requisitos de Arquitectura de Negocio (B-02), que expresa la misma arquitectura en términos cuantitativos y medibles.

1.2 Correspondencia con las salidas de la Fase B

La Guía de Bolsillo de TOGAF 9.1 establece las salidas que deben producirse al completar la Fase B (Josey, 2011, cap. 2.3.3). La tabla siguiente muestra dónde se satisface cada una.

Tabla 4
Correspondencia entre las salidas de la Fase B y este documento

Salida exigida por TOGAF	Dónde se satisface	Evidencia
Declaración de Trabajo de Arquitectura, actualizada si fuera necesario	Capítulo 9	Evaluación de los cinco disparadores de cambio; emisión de A-02 v2.1 con actualización de estado, sin cambio de alcance
Principios de negocio validados, objetivos de negocio y motivaciones de negocio	Secciones 2.2.1 a 2.2.3 y 2.3.1	Tablas 8, 9, 10 y 12, con estado de validación y fuente
Principios de arquitectura de negocio bien elaborados	Sección 2.3	Tablas 12, 13 y 14, con enunciado, fundamento, implicaciones, indicador y responsable
Versión preliminar del Documento de Definición de la Arquitectura con la arquitectura de negocio de línea base y de destino	Secciones 2.4 y 2.5	Procesos, capacidades, actores, escenarios y vistas en versión 1.0
Especificación de Requisitos de Arquitectura (complemento cuantitativo)	B-02	Entregable separado, aprobado en el mismo Hito H2
Componentes candidatos del Plan de Itinerario (complemento de TOGAF)	Capítulo 8	Componentes, factores de implementación, matriz de dependencias y recomendaciones

1.3 Entradas y salidas

Tabla 5
Entradas y salidas del documento

Tipo	Elemento	Uso en este documento
Entrada	Petición de Trabajo de Arquitectura D-06	Origen del proyecto y de los cinco cambios solicitados
Entrada	A-01 Visión de la Arquitectura v2.1	Metas, impulsores, principios, objetivos, interesados, KPI y escenario EB-01
Entrada	A-02 Declaración de Trabajo v2.1	Alcance, plan, criterios de aceptación y procedimiento de cambio
Entrada	A-03 Plan de Comunicaciones	Interesados, mensajes y calendario de validación
Entrada	A-04 Evaluación de Capacidades	Capacidades CB-01 a CB-10, factores de preparación y brechas BR-01 a BR-08
Entrada	A-05 Definición de la Arquitectura v2.1	Arquitecturas base y objetivo (negocio 1.0; datos, aplicaciones y tecnología 0.1), procesos y transiciones
Entrada	TOGAF 9.1 y guía de bolsillo	Método, plantillas y criterios de contenido

Tipo	Elemento	Uso en este documento
Salida	Arquitectura de negocio base y objetivo v1.0	Insumo para C-01, C-02, C-03 y TEC-01
Salida	Componentes candidatos del Plan de Itinerario	Insumo para E-01 y E-02
Salida	Requisitos de negocio refinados	Registro GR-01 y B-02
Salida	Decisiones de arquitectura de negocio	Registro GV-01

1.4 Relación con los demás entregables

Tabla 6
Relación de B-01 con los entregables del proyecto

Entregable	Relación
A-01 Visión de la Arquitectura	B-01 valida y elabora sus metas, objetivos, impulsores y principios; no los reemplaza
A-02 Declaración de Trabajo	B-01 evalúa su vigencia y propone la versión 2.1 solo por actualización de estado
A-04 Evaluación de Capacidades	B-01 usa sus capacidades y brechas como línea base y las traduce en cambios de negocio
A-05 Definición de la Arquitectura	B-01 eleva la arquitectura de negocio de 0.1 a 1.0; las demás capas siguen en 0.1
B-02 Especificación de Requisitos	B-02 cuantifica los requisitos, contratos de servicio y medidas de éxito de esta arquitectura
C-01, C-02, C-03	Reciben procesos, entidades, actores y requisitos de negocio como insumo
E-01, E-02	Reciben los componentes candidatos y los estados de transición propuestos
GR-01 y GV-01	Reciben requisitos y decisiones para su registro y seguimiento

1.5 Convenciones de identificadores

- **OEI**: objetivo estratégico institucional.
- **BG**: meta de negocio.
- **OA**: objetivo de arquitectura.
- **IC**: impulsor de cambio (*business driver*).
- **PA**: principio de arquitectura.
- **PN**: principio de negocio.
- **CB**: capacidad de negocio.
- **P**: proceso de negocio de nivel 2.
- **EB**: escenario de negocio.
- **RQ**: requisito de interesado o de negocio.
- **BR**: brecha.
- **ABB**: bloque de construcción de arquitectura.
- **TA**: estado de transición.
- **IF**: interfaz.

- **KPI**: indicador clave de desempeño.
- **DA**: decisión de arquitectura.
- **CN**: restricción.
- **S**: supuesto.
- **R**: riesgo.
- **SC**: solicitud de cambio.

Los identificadores heredados de la Fase A conservan su numeración y significado. Los nuevos elementos de la Fase B se numeran a continuación del último código existente.

---

2. Definición de la arquitectura de negocio

2.1 Alcance

El alcance de la arquitectura de negocio es el acordado en A-02 y se expresa en las cuatro dimensiones de TOGAF (The Open Group, 2011, cap. 7).

Tabla 7
Alcance de la arquitectura de negocio

Dimensión	Definición
Amplitud	Hospital de Tingo María, con foco en la cadena de atención de consulta externa: citas, admisión, triaje, consulta, órdenes de laboratorio e imágenes, resultados, prescripción, dispensación, registro de la prestación y seguimiento. Hospitalización y emergencia se modelan solo como contexto.
Profundidad	Nivel estratégico y de segmento: procesos de nivel 1 y 2, mapa de capacidades, actores y roles, escenarios de negocio y principios. No incluye diseño detallado de procedimientos ni de soluciones.
Horizonte temporal	Arquitectura de negocio objetivo a 24 meses; desarrollo de la arquitectura en seis meses (Mes 1 a Mes 6).
Dominios	Negocio, con las dependencias hacia datos, aplicaciones y tecnología identificadas y transferidas a las Fases C y D.

La Figura 1 ubica el alcance dentro de la operación del hospital y muestra los procesos incluidos, los procesos de contexto y los actores externos.

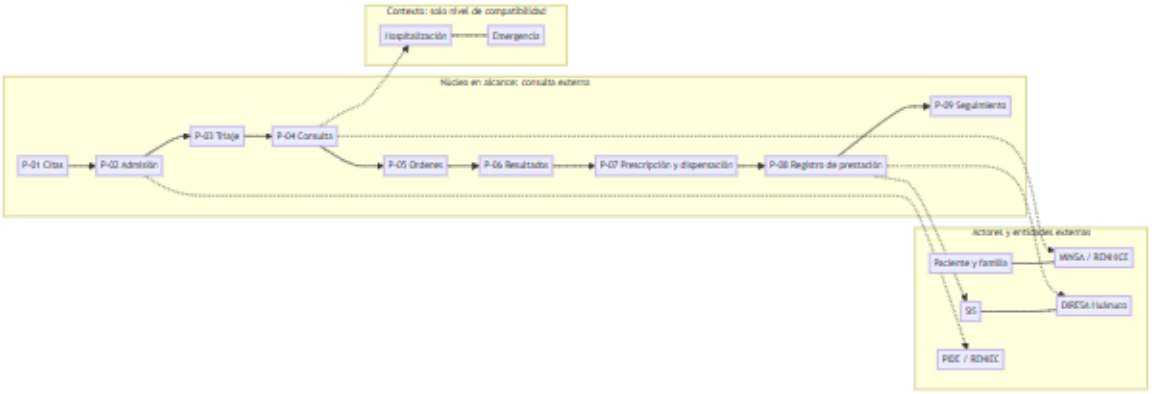


Figura 1

Mapa de alcance de la arquitectura de negocio

Nota. El núcleo en alcance se modela en detalle; hospitalización y emergencia solo se consideran para asegurar que el expediente sea compatible en iteraciones posteriores.

2.2 Metas, objetivos y restricciones

2.2.1 Metas de negocio

Las metas de negocio (BG) se confirmaron en la Fase A y se validaron en la Fase B con la Dirección Ejecutiva y Planeamiento y Presupuesto. La validación consistió en verificar que cada meta siguiera expresando un resultado deseado del hospital y que tuviera al menos un objetivo de arquitectura y un indicador asociados.

Tabla 8

Metas de negocio validadas

Código	Meta de negocio	Precisión para la arquitectura de negocio	OEI relacionado	Estado de validación	Evidencia
BG-001	Velar por la salud de los ciudadanos	Información clínica completa y oportuna de cada paciente en todos los servicios	OEI.01, OEI.02, OEI.03	Validada	Acta de validación con la Dirección Asistencial (Apéndice C)
BG-002	Brindar una atención buena y rápida	Reducción de tiempos de espera y de repetición de trámites en consulta externa	OEI.03	Validada	Acta de validación con jefaturas médicas (Apéndice C)
BG-003	Fortalecer la capacitación y el aprendizaje	Formación continua y medible del personal de salud	OEI.04	Validada	Oficio de la Oficina de Recursos Humanos
BG-004	Fortalecer la gestión estratégica institucional	Indicadores estratégicos con datos vigentes para la toma de decisiones	OEI.01 a OEI.04	Validada con observación	Planeamiento confirma la meta y deja pendiente la vigencia del instrumento (S-A-01)

Nota. La validación de BG-004 es condicional: la meta se mantiene, pero su indicador no podrá medirse hasta que Planeamiento confirme la vigencia del instrumento de planificación estratégica. Esta condición se registra en B-02 como supuesto y en el capítulo 10 como riesgo.

2.2.2 Objetivos de arquitectura

Los objetivos de arquitectura (OA) traducen las metas en resultados verificables. En la Fase B se revisó que cada objetivo cumpliera el criterio SMART y que tuviera un KPI con línea base o procedimiento de medición.

Tabla 9

Objetivos de arquitectura validados y criterio SMART

Código	Objetivo de arquitectura	Meta	KPI	Específico	Medible	Alcanzable	Realista	Con plazo
OA-01	Expediente clínico electrónico único, accesible y completo por paciente	BG-001	KPI-01	Sí	Sí	Sí, por etapas	Sí, con financiamiento por etapas	24 meses
OA-02	Reducir el tiempo de espera en consulta externa	BG-002	KPI-02	Sí	Sí	Sí, con rediseño de procesos	Sí, foco en una cadena	24 meses
OA-03	Proteger los datos clínicos con control de acceso, cifrado y auditoría	BG-001	KPI-03	Sí	Sí	Sí	Sí, con servicio transversal	24 meses
OA-04	Habilitar la interoperabilidad con la DIRESA, el MINSA y el SIS	BG-004	KPI-04	Sí	Sí	Condicionada a terceros	Sí, con interfaces priorizadas	24 meses
OA-05	Formalizar y poner en operación la función de arquitectura	BG-004	KPI-05	Sí	Sí	Sí	Sí, con decisión de la Dirección	Mes 2
OA-06	Disponer de una plataforma de capacitación y aprendizaje	BG-003	KPI-06	Sí	Sí	Sí	Sí, con plataforma existente o libre	24 meses
OA-07	Disponer de un tablero de control con indicadores estratégicos	BG-004	KPI-07	Sí	Sí	Condicionada a datos	Sí, con fuentes priorizadas	24 meses

Nota. La columna "Alcanzable" distingue los objetivos que dependen solo del hospital de aquellos que dependen de decisiones de terceros (OA-04 y OA-07). Para estos últimos, el plan de la Fase B incluye acuerdos tempranos con las contrapartes.

2.2.3 Motivaciones de negocio

Los impulsores de cambio (IC) explican por qué el hospital debe cambiar ahora. En la Fase B se validó su vigencia y se clasificaron por tipo y prioridad.

Tabla 10

Motivaciones de negocio validadas

Código	Motivación	Tipo	Evidencia	Prioridad	Vigencia en Fase B
IC-01	Marco nacional de historia clínica electrónica (RENHICE)	Externo, normativo	Ley N.° 30024; D.S. N.° 009-2017-SA; NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN	Alta	Vigente
IC-02	Obligaciones de gobierno digital e interoperabilidad	Externo, normativo	D. Leg. N.° 1412; D.S. N.° 029-2021-PCM	Media	Vigente
IC-03	Protección reforzada de datos de salud	Externo, normativo	Ley N.° 29733	Alta	Vigente
IC-04	Financiamiento del SIS ligado al registro de atenciones	Externo, financiero	Normativa del SIS	Alta	Vigente
IC-05	Historias clínicas dispersas y duplicación de registros	Interno, operativo	A-04, sección 3	Alta	Confirmado
IC-06	Tiempos de espera elevados y reprocesos	Interno, operativo	Petición D-06; A-01, sección 12	Alta	Confirmado
IC-07	Infraestructura frágil ante cortes de energía y conectividad	Interno, tecnológico	A-04, sección 4	Alta	Confirmado
IC-08	Ausencia de gobierno del cambio tecnológico	Interno, de gobierno	A-04, sección 5	Crítica	Confirmado
IC-09	Coordinación de referencias y reportes con DIRESA y MINSA	Externo, estratégico	Requisitos de reporte sectorial	Alta	Vigente

Nota. La vigencia normativa se verificó a la fecha de emisión del documento. Cambios posteriores en la normativa sectorial deben evaluarse mediante el procedimiento de cambio de A-02.

2.2.4 Restricciones de negocio

Tabla 11

Restricciones que condicionan la arquitectura de negocio

Código	Restricción	Ámbito	Efecto en el negocio	Fuente
CN-B-01	La atención no puede detenerse durante ningún cambio	Procesos y personas	Toda transición exige coexistencia, contingencia y reversión	CN-F-02; PA-02
CN-B-02	Los datos de salud son sensibles y su tratamiento es reforzado	Información y roles	Acceso por rol, justificación de acceso y auditoría	LE-01; CN-F-01
CN-B-03	Toda historia clínica electrónica debe alinearse con el RENHICE y la NTS N.° 139	Procesos y registros	El registro clínico y su conservación siguen la norma técnica	LE-02; Ley N.° 30024
CN-B-04	El presupuesto anual es cerrado y no admite recursos extraordinarios	Financiamiento	Implementación por etapas y priorización por valor	PB-01; CN-F-03
CN-B-05	La interoperabilidad sectorial depende de la DIRESA y del MINSA	Procesos de reporte	Las interfaces se planifican con margen y con mecanismos alternativos	LE-03
CN-B-06	El horario de atención y la carga asistencial limitan las sesiones de trabajo	Personas	Validaciones en sesiones cortas y fuera de horas de mayor demanda	LO-06

2.3 Principios

2.3.1 Principios de negocio validados

Los principios de negocio expresan las reglas duraderas que orientan las decisiones del hospital sobre sus procesos, sus roles y su información. Se derivan de la misión, de las metas BG y de los principios de arquitectura PA, y se validaron con la Dirección Ejecutiva y la Dirección Asistencial. Se codifican como PN para no confundirlos con las limitaciones presupuestarias PB de A-02.

Tabla 12

Principios de negocio validados

Código	Nombre	Enunciado	Fundamento	Implicaciones	Indicador de cumplimiento	Responsable
PN-01	El paciente es el centro de la atención	Los procesos se diseñan desde la experiencia del paciente y no desde la conveniencia de cada servicio	La misión del hospital y la meta BG-001 lo exigen; la fragmentación actual es la principal causa del problema (A-01, sección 9.1)	Una sola admisión; el paciente no traslada documentos ni repite datos; los tiempos se miden de punta a punta	KPI-02; encuesta de experiencia del paciente	Dirección Asistencial
PN-02	La información se registra una sola vez y se comparte	Todo dato clínico se captura en el punto donde se genera y se reutiliza en los demás procesos	La duplicación de registros consume tiempo clínico y genera errores (IC-05)	Identificador único; expediente compartido; interfaces en lugar de redigitación	KPI-01; porcentaje de campos redigitados	Dirección Asistencial y OSI
PN-03	La continuidad de la atención prevalece	Ningún cambio tecnológico puede interrumpir la atención	Es una obligación legal y ética; principio PA-02	Coexistencia, modo de contingencia, registro en papel con carga posterior y reversión	Incidentes con interrupción de atención; disponibilidad	Dirección Asistencial y OSI
PN-04	Privacidad y consentimiento	Solo accede a la información clínica quien tiene un rol asistencial o una autorización válida	Los datos de salud son sensibles (Ley N.° 29733) y el paciente debe confiar en el hospital	Acceso por rol, justificación de acceso a datos restringidos, auditoría y consentimiento informado	KPI-03; revisiones de auditoría	Dirección Ejecutiva y OSI
PN-05	Decisión basada en evidencia y mejora continua	Las decisiones de cambio se sustentan en datos medidos y se revisan periódicamente	La meta BG-004 y el principio PA-06 lo requieren; hoy los indicadores se consolidan manualmente	Línea base antes de cambiar; tablero de indicadores; revisión en el ARB	KPI-07; porcentaje de decisiones con evidencia	Planeamiento y Presupuesto

Nota. Los principios PN-01 a PN-05 no reemplazan a los principios de arquitectura PA-01 a PA-08; los orientan desde el negocio. Su cumplimiento se verifica en las revisiones de arquitectura y en la Fase G.

2.3.2 Principios de arquitectura de negocio elaborados

Los ocho principios de arquitectura confirmados en A-01 se elaboran aquí para el dominio de negocio: se explicita qué significan para los procesos, los roles y la información, y cómo se verifica su cumplimiento.

Tabla 13

Principios de arquitectura elaborados para el dominio de negocio

Código	Nombre	Enunciado	Lectura para el negocio	Implicaciones en procesos y roles	Verificación	Dueño
PA-01	Primacía de los principios	Todas las áreas aplican los principios en sus decisiones de información y tecnología	Ningún servicio puede adoptar una solución que contradiga la arquitectura aprobada	Las excepciones se solicitan al ARB y quedan registradas; las jefaturas participan en la revisión	Acta del ARB; registro GV-01	Dirección Ejecutiva
PA-02	Continuidad del servicio	La atención no se interrumpe por fallas o cambios tecnológicos	El negocio debe poder operar incluso sin sistema	Procedimiento de contingencia en cada proceso crítico; coexistencia durante la transición	Pruebas de contingencia; incidentes	Dirección Asistencial
PA-03	Control de acceso	Cada usuario accede solo a la información que su rol requiere	Los roles clínicos y administrativos se definen antes de habilitar accesos	Matriz de acceso por rol; revisión periódica; baja oportuna de accesos	KPI-03; auditoría de accesos	OSI
PA-04	Seguridad de los datos	La información clínica se protege en confidencialidad, integridad y disponibilidad	El paciente debe confiar en que su información no se altera ni se divulga	Cifrado, auditoría inalterable, datos de prueba anonimizados	Auditoría; pruebas de seguridad	OSI
PA-05	Facilidad de uso	Las aplicaciones se diseñan alrededor del trabajo real del personal clínico	El registro debe caber en el tiempo de la consulta, no agregar trabajo al final del día	Pruebas de usabilidad con médicos y enfermería antes de cada despliegue; ajuste de formularios	Pruebas de usabilidad; adopción	Dirección Asistencial
PA-06	Respuesta gestionada al cambio	Los cambios se evalúan y aprueban antes de ejecutarse	Ningún servicio cambia su forma de trabajar por decisión aislada de un proveedor	Solicitud de cambio; evaluación de impacto; comunicación al personal	Registro de cambios; actas	ARB
PA-07	Adaptabilidad	La arquitectura crece por etapas y se adapta a nuevos servicios y normas	El negocio debe poder incorporar nuevas prestaciones sin rehacer todo	Procesos modulares; estándares abiertos; componentes reemplazables	Revisiones de arquitectura	Arquitecto líder

Código	Nombre	Enunciado	Lectura para el negocio	Implicaciones en procesos y roles	Verificación	Dueño
PA-08	Los datos son un activo compartido	Los datos maestros tienen dueño, fuente única y calidad medida	Paciente, profesional y servicio deben identificarse una sola vez	Dueños de datos designados; reglas de calidad; depuración de duplicados	Indicadores de calidad de datos	Dirección Asistencial y OSI

2.3.3 Cumplimiento de principios en las decisiones de negocio

Tabla 14

Relación entre principios y decisiones de la arquitectura de negocio

Decisión de negocio	Principios que la gobiernan	Cómo se cumple
Una sola admisión y identificador único	PN-02, PA-08	El paciente se identifica una vez; el índice maestro es la fuente única
Historia clínica única y compartida	PN-01, PN-02, PA-08	El expediente concentra la información; los servicios consultan la misma fuente
Órdenes y resultados en línea	PN-02, PA-07	Órdenes electrónicas e interfaces con laboratorio e imágenes
Prescripción electrónica y dispensación sin redigitación	PN-02, PA-05	La receta viaja con el paciente y farmacia valida contra el catálogo
Registro automático de la prestación	PN-02, PN-05	La prestación se genera desde la atención y se envía al SIS
Acceso por rol y auditoría	PN-04, PA-03, PA-04	Matriz de acceso y registro inalterable de cada consulta
Contingencia ante cortes	PN-03, PA-02	Modo local y procedimiento en papel con carga posterior
Validación con jefaturas antes de cambiar	PN-05, PA-06	Talleres de validación y actas por escenario

---

2.4 Arquitectura de negocio de línea base

La arquitectura de línea base describe el negocio tal como opera hoy, con el nivel de detalle necesario para justificar el cambio. No es un inventario exhaustivo de procedimientos: es una descripción de la cadena de valor, las capacidades, los procesos y los actores que explican el problema identificado en A-01 y evaluado en A-04.

2.4.1 Cadena de valor del paciente (AS-IS)

La cadena de valor actual se organiza alrededor de las etapas clínicas, pero cada etapa opera con sus propios registros, horarios y criterios. El paciente es el único elemento que conecta las etapas, y lo hace llevando documentos físicos y repitiendo información.

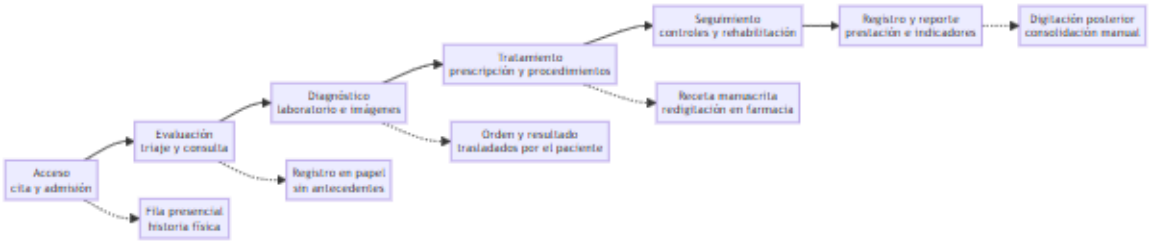


Figura 2

Cadena de valor del paciente: situación actual (AS-IS)

Nota. Las líneas punteadas señalan los puntos de ruptura de la información que explican la mayor parte del tiempo perdido y de los reprocesos.

La lectura por etapa es la siguiente:

4. **Acceso.** El paciente hace fila para obtener un turno el mismo día. Admisión busca la historia física en archivo y, si no la encuentra, inicia un registro nuevo. No hay cita programada por especialidad ni control del tiempo de espera.
5. **Evaluación.** Enfermería registra signos vitales en papel. El médico recibe al paciente sin los resultados de exámenes previos y con una historia que puede estar incompleta.
6. **Diagnóstico.** El médico escribe la orden en papel; el paciente la lleva al laboratorio o a imágenes. El resultado se entrega impreso y el paciente debe recogerlo y volver a consulta.
7. **Tratamiento.** La receta se escribe a mano. Farmacia vuelve a registrar los datos del paciente y del medicamento, y no siempre puede verificar la interacción con otros tratamientos.
8. **Seguimiento.** Los controles se programan manualmente; no hay recordatorio ni visibilidad de la evolución funcional del paciente.
9. **Registro y reporte.** La prestación se digita después en los aplicativos sectoriales. Los indicadores se consolidan manualmente para el Plan Operativo Institucional.

2.4.2 Capacidades de negocio (AS-IS)

Las diez capacidades evaluadas en A-04 se describen aquí en términos de negocio: qué habilidad tiene hoy el hospital, cómo la realiza y qué consecuencia produce su nivel actual.

Tabla 15

Capacidades de negocio en la línea base

Código	Capacidad	Nivel actual	Cómo se realiza hoy	Consecuencia para el negocio	Evidencia
CB-01	Atención y continuidad del cuidado del paciente	3	Cada servicio atiende con sus propios registros y horarios; la continuidad depende de que el paciente lleve sus documentos	El paciente repite su historia y la atención se fragmenta entre servicios	A-04, Tabla 10
CB-02	Gestión de la información clínica	2	Historia en papel complementada con registros digitales aislados; búsqueda manual en archivo; posibles duplicados	El médico decide sin información completa; se repiten exámenes	A-04, Tabla 10
CB-03	Gestión administrativa y financiera	3	Sistemas administrativos del sector público para presupuesto, logística y finanzas	No requiere cambios en esta iteración; se integra como contexto	A-04, Tabla 10
CB-04	Abastecimiento y farmacia	2	Receta manuscrita; farmacia vuelve a registrar datos; control de stock en sistema sectorial	Errores de dispensación y demoras; no hay trazabilidad de la prescripción	A-04, Tabla 10
CB-05	Seguridad y privacidad de la información	3	Usuarios y contraseñas en algunos sistemas, sin perfiles por rol ni auditoría sistemática	Riesgo de acceso indebido a datos sensibles	A-04, Tabla 10
CB-06	Interoperabilidad sectorial	1	Reportes al sector elaborados y enviados en gran parte de forma manual	Prestaciones no registradas o reportadas tarde; pérdida de financiamiento	A-04, Tabla 10
CB-07	Gestión de citas y del flujo de atención	1	Turnos en fila presencial el mismo día; sin control del tiempo de espera	Esperas largas y percepción negativa del servicio	A-04, Tabla 10
CB-08	Apoyo al diagnóstico	2	Órdenes escritas que el paciente traslada; resultados impresos	Retraso entre orden, resultado y decisión clínica	A-04, Tabla 10
CB-09	Gestión estratégica e indicadores	1	Indicadores consolidados manualmente para el Plan Operativo	Decisiones sin datos vigentes; esfuerzo administrativo alto	A-04, Tabla 10
CB-10	Desarrollo y capacitación del personal	2	Capacitaciones esporádicas, sin registro centralizado de horas	No se puede demostrar el cumplimiento de horas ni la adopción del cambio	A-04, Tabla 10

2.4.3 Procesos de negocio (AS-IS)

Los procesos de nivel 2 de la consulta externa se describen con su disparador, entradas, actividades principales, salidas, actores y soporte actual. Los tiempos se están midiendo en la semana 10 como línea base de KPI-02; por eso se indican como "por confirmar" y no se presentan valores estimados como si fueran evidencia.

Tabla 16

Procesos de la consulta externa en la línea base

Código	Proceso	Disparador	Entradas	Actividades principales	Salidas	Actores	Soporte actual	Tiempo actual
P-01	Programación de citas	Llegada del paciente o llamada	Demanda del día; disponibilidad del médico	Asignar turno por orden de llegada; registrar en agenda manual	Turno asignado	Paciente, admisión	Agenda física o libro	Por confirmar (medición semana 10)
P-02	Admisión	Turno asignado	Documento de identidad; historia física	Buscar historia; registrar datos; derivar a triaje	Admisión registrada	Paciente, admisión, archivo	Registro manual y sistemas separados	Por confirmar
P-03	Triaje	Admisión registrada	Datos del paciente	Medir signos vitales; registrar prioridad	Registro de triaje en papel	Enfermería	Formato de papel	Por confirmar
P-04	Consulta médica	Triaje concluido	Historia física; resultados previos si el paciente los trae	Entrevista; examen; diagnóstico; órdenes y receta	Diagnóstico, órdenes y receta manuscrita	Médico, paciente	Historia física; sin resultados en línea	Por confirmar
P-05	Órdenes de apoyo al diagnóstico	Consulta con orden	Orden escrita	Entregar orden al paciente; derivar al servicio	Orden recibida por laboratorio o imágenes	Médico, paciente, laboratorio	Papel	Por confirmar
P-06	Resultados	Examen procesado	Muestra o estudio	Procesar; imprimir; entregar al paciente	Resultado impreso	Laboratorio, imágenes, paciente	Registro del servicio; papel	Por confirmar
P-07	Prescripción y dispensación	Consulta con receta	Receta manuscrita	Validar receta; registrar datos; dispensar	Medicamento entregado; registro de farmacia	Médico, farmacia, paciente	Receta manuscrita; sistema de stock	Por confirmar
P-08	Registro de la prestación	Atención concluida	Datos de la atención	Digitar en aplicativos sectoriales; enviar reportes	Prestación registrada	Estadística, OSI	Aplicativos sectoriales; digitación	Por confirmar
P-09	Seguimiento	Alta de consulta	Indicación de control	Programar control; registrar asistencia	Cita de control	Médico, admisión, paciente	Agenda manual	Por confirmar

Nota. La línea base de tiempos y de completitud se mide en las semanas 9 y 10 con la Dirección Asistencial, conforme al criterio específico de aceptación de la Fase B (A-02, Tabla 20). Los valores definitivos se incorporan a B-02, Tabla 6.

2.4.4 Actores y roles (AS-IS)

Tabla 17

Actores y roles de negocio en la línea base

Actor	Rol actual	Unidad organizativa	Procesos en los que participa	Dolor principal	Cambio esperado en la arquitectura objetivo
Paciente y familia	Usuario del servicio	Externo	P-01 a P-09	Repite datos y trámites; espera sin información	Atención más rápida y sin repetición de datos
Personal de admisión y citas	Registrador de la admisión	Dirección de Administración	P-01, P-02, P-09	Busca historias físicas y lidia con duplicados	Pasa a gestionar citas y validar identidad en el sistema
Personal de archivo	Custodio de la historia física	Dirección Asistencial	P-02, P-04	Archivo incompleto y búsqueda lenta	Apoyo a la digitalización y a la gestión documental
Personal de enfermería	Responsable del triaje	Dirección Asistencial	P-03, P-07	Registro en papel que luego se transcribe	Registro directo en el expediente
Médico	Profesional tratante	Departamentos médicos	P-04 a P-09	Decide sin antecedentes ni resultados completos	Información completa en una sola pantalla
Personal de laboratorio e imágenes	Ejecutor del apoyo al diagnóstico	Servicios de apoyo	P-05, P-06	Órdenes ambiguas y entrega manual de resultados	Órdenes electrónicas y resultados en línea
Personal de farmacia	Dispensador	Servicios de apoyo	P-07	Redigita datos y no ve la prescripción completa	Dispensación con receta electrónica y stock
Personal de estadística	Responsable del registro y reporte	OSI	P-08	Digitación tardía y reportes incompletos	Prestación generada desde la atención
Dirección y Planeamiento	Usuario de indicadores	Dirección Ejecutiva; Planeamiento	P-08, P-09	Indicadores manuales y desactualizados	Tablero con datos vigentes

2.4.5 Escenarios de negocio

Tabla 18

Escenarios de negocio y su estado en la Fase B

Código	Escenario	Dominios involucrados	Estado en A-05	Tratamiento en B-01
EB-01	Atención en consulta externa, desde la cita hasta la dispensación	Todos	Desarrollado en A-01	Se actualiza con el proceso objetivo y se valida con jefaturas
EB-02	Consulta de la historia clínica por el médico tratante	Datos, aplicaciones, tecnología	Por desarrollar en la Fase B	Se desarrolla en la sección 2.5.5
EB-03	Registro y envío de la prestación de un asegurado al SIS	Negocio, datos, aplicaciones	Por desarrollar en la Fase B	Se desarrolla en la sección 2.5.5
EB-04	Atención durante un corte de energía o de conectividad	Negocio, tecnología	Por desarrollar en la Fase D	Se mantiene como dependencia de PA-02 y del modo de contingencia

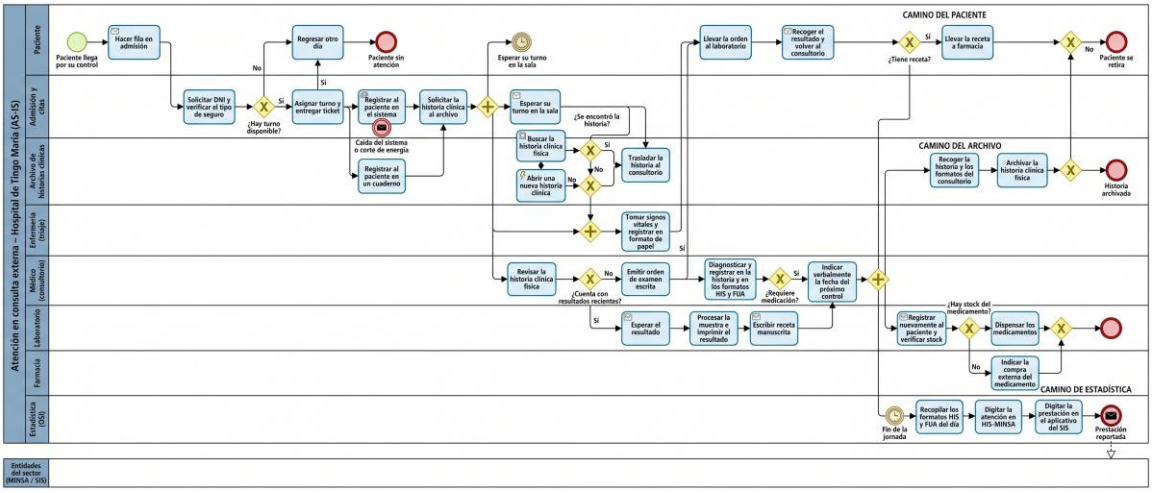


Figura 3

Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación actual (AS-IS)

Nota. Modelo BPMN 2.0 elaborado en Bizagi Modeler a partir de A-01, sección 12.4. Elaboración propia.

2.5 Arquitectura de negocio objetivo

La arquitectura objetivo reorganiza la cadena de valor alrededor del paciente y de la información compartida. No cambia la misión del hospital ni sus funciones; cambia la forma en que se coordinan los servicios para cumplirla.

2.5.1 Cadena de valor del paciente (TO-BE)

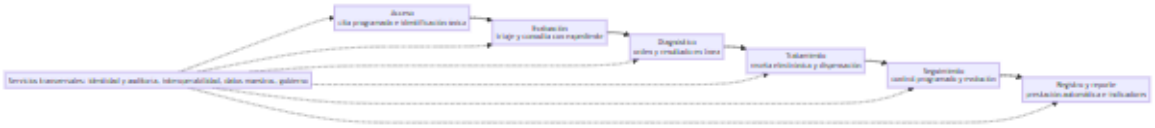


Figura 4

Cadena de valor del paciente: situación objetivo (TO-BE)

Nota. La etapa de acceso incorpora la cita programada y la identificación única; la etapa de registro y reporte deja de ser una tarea administrativa posterior y se genera desde la atención.

Los cambios por etapa son:

10. **Acceso.** El paciente accede por cita programada o por demanda controlada; se identifica con su documento validado en línea y el sistema recupera o crea su identificador único. El tiempo de espera se mide y se muestra.
11. **Evaluación.** Enfermería registra signos vitales y prioridad directamente en el expediente. El médico abre una sola pantalla con antecedentes, atenciones previas, diagnósticos, órdenes y resultados.
12. **Diagnóstico.** La orden se genera electrónicamente y llega al servicio; el resultado se registra en el expediente y se notifica al médico. El paciente no traslada documentos.
13. **Tratamiento.** La receta se emite electrónicamente, se valida contra el catálogo y el stock, y farmacia dispensa sin volver a registrar datos.

14. **Seguimiento.** La cita de control se genera desde la consulta; el médico ve la evolución funcional y los controles pendientes.
15. **Registro y reporte.** La prestación se construye a partir de la atención y se envía al SIS y al sector; el tablero de indicadores se alimenta de los datos registrados.

2.5.2 Capacidades de negocio objetivo

Tabla 19

Capacidades de negocio objetivo y su contribución

Código	Capacidad	Nivel objetivo	Cambio principal	ABB que la habilita	KPI asociado	Prioridad
CB-01	Atención y continuidad del cuidado del paciente	4	Cadena organizada alrededor del paciente, con información compartida	BB-01, BB-03	KPI-01, KPI-02	Alta
CB-02	Gestión de la información clínica	4	Expediente único, alineado al RENHICE, con identificador único	BB-01, BB-02	KPI-01	Alta
CB-03	Gestión administrativa y financiera	3	Sin cambios en esta iteración; integración futura	—	—	Contexto
CB-04	Abastecimiento y farmacia	4	Receta electrónica conectada al expediente y al stock	BB-01	KPI-01	Media
CB-05	Seguridad y privacidad de la información	4	Control de acceso por rol, cifrado y auditoría	BB-04	KPI-03	Alta
CB-06	Interoperabilidad sectorial	4	Intercambio automatizado con estándares abiertos	BB-05	KPI-04	Alta
CB-07	Gestión de citas y del flujo de atención	4	Citas programadas y seguimiento del tiempo por etapa	BB-03	KPI-02	Alta
CB-08	Apoyo al diagnóstico	4	Órdenes electrónicas y resultados en el expediente	BB-01	KPI-01	Media
CB-09	Gestión estratégica e indicadores	4	Tablero alimentado desde el expediente y los sistemas sectoriales	BB-06	KPI-07	Media
CB-10	Desarrollo y capacitación del personal	4	Plan anual con plataforma y registro de horas	BB-07	KPI-06	Media

La Figura 5 compara el nivel actual con el objetivo de cada capacidad.

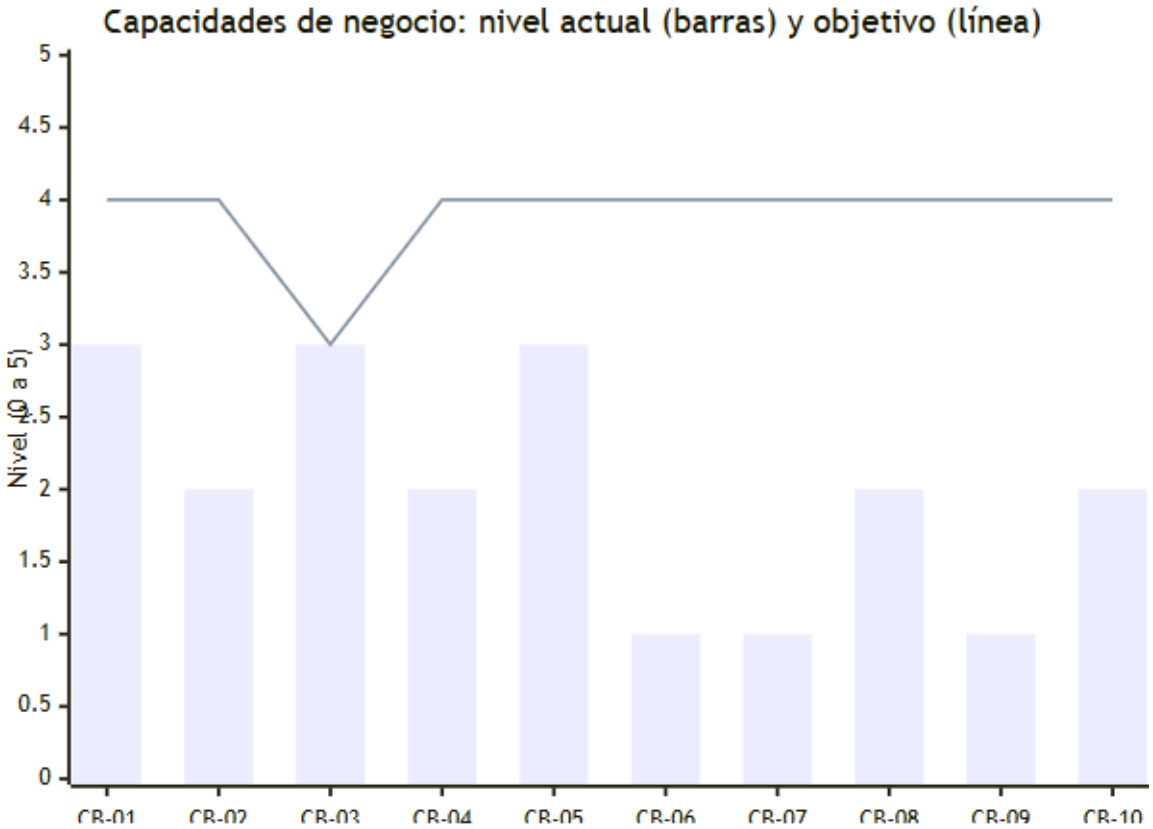


Figura 5

Capacidades de negocio: nivel actual y objetivo

Nota. Si el visor de Markdown no muestra el gráfico, los mismos valores se encuentran en las Tablas 15 y 19.

2.5.3 Procesos de negocio objetivo

Tabla 20

Procesos de la consulta externa en la arquitectura objetivo

Código	Proceso	Disparador	Entradas	Actividades objetivo	Salidas	Actores	Soporte objetivo	Nivel de servicio	KPI
P-01	Programación de citas	Solicitud del paciente o indicación médica	Demanda; agenda por especialidad	Ofrecer cupos por canal presencial o telefónico; confirmar cita; recordar	Cita confirmada	Paciente, admisión	AP-02 Citas	Confirmación en menos de 5 minutos	KPI-02
P-02	Admisión	Llegada del paciente con cita o por demanda	Documento de identidad	Validar identidad; recuperar o crear identificador único; registrar admisión	Admisión registrada	Paciente, admisión	AP-02, AP-03, AP-06	Admisión en 5 minutos o menos	KPI-02
P-03	Triaje	Admisión registrada	Datos del paciente	Medir signos vitales; registrar prioridad en el expediente	Registro de triaje	Enfermería	AP-01 Expediente	Triaje en 10 minutos o menos	KPI-01
P-04	Consulta médica	Triaje concluido	Expediente completo	Revisar antecedentes y resultados; examinar; diagnosticar con CIE-10; emitir órdenes y receta	Diagnóstico, órdenes y receta electrónica	Médico, paciente	AP-01	Consulta con información completa	KPI-01
P-05	Órdenes de apoyo al diagnóstico	Consulta con orden	Diagnóstico y justificación clínica	Generar orden electrónica; enviar al servicio; priorizar	Orden recibida en línea	Médico, laboratorio, imágenes	AP-01, interfaz IF-08	Orden disponible al instante	KPI-01
P-06	Resultados	Examen procesado	Muestra o estudio	Procesar; registrar resultado; notificar al médico	Resultado en el expediente	Laboratorio, imágenes, médico	AP-01, IF-08	Resultado disponible en el expediente	KPI-01
P-07	Prescripción y dispensación	Consulta con receta	Diagnóstico y prescripción	Validar receta contra catálogo y stock; dispensar; registrar	Medicamento entregado y registrado	Médico, farmacia, paciente	AP-01, IF-09	Dispensación sin redigitación	KPI-01
P-08	Registro de la prestación	Atención concluida	Datos de la atención	Generar prestación; validar; enviar al SIS y al sector	Prestación reportada	Estadística, OSI	AP-01, AP-05, IF-07	Reporte dentro del plazo del SIS	KPI-04

Código	Proceso	Disparador	Entradas	Actividades objetivo	Salidas	Actores	Soporte objetivo	Nivel de servicio	KPI
P-09	Seguimiento	Alta de consulta	Indicación de control	Generar cita de control; registrar asistencia; ver evolución	Cita de control y seguimiento	Médico, admisión, paciente	AP-01, AP-02	Control programado antes del alta	KPI-01

Nota. Los niveles de servicio son metas de la arquitectura y se validan en la Fase F con los responsables de cada proceso. No sustituyen los acuerdos de nivel de servicio que se formalicen en los contratos de la Fase G.

2.5.4 Actores y roles objetivo

Tabla 21

Cambios en actores y roles

Actor	Rol actual	Rol objetivo	Cambio	Impacto	Necesidad de capacitación
Paciente y familia	Usuario que traslada documentos	Usuario informado y partícipe de su atención	Recibe información de tiempos y resultados; no repite datos	Alto	Comunicación en salas de espera
Personal de admisión y citas	Registrador manual	Gestor de citas y validador de identidad	Usa agenda y validación en línea	Alto	Manejo de AP-02 y AP-03
Personal de archivo	Custodio de la historia física	Apoyo a digitalización y gestión documental	Deja de buscar historias para cada atención	Alto	Digitalización y control de calidad
Personal de enfermería	Registrador en papel	Registrador clínico en el expediente	Registra triaje y cuidados en AP-01	Alto	Uso clínico del expediente
Médico	Decisor con información parcial	Decisor con información completa	Consulta antecedentes, resultados y órdenes en una pantalla	Muy alto	Uso clínico, CIE-10 y receta electrónica
Personal de laboratorio e imágenes	Receptor de órdenes en papel	Gestor de órdenes y resultados en línea	Recibe y responde órdenes electrónicas	Medio	Flujo de órdenes y resultados
Personal de farmacia	Registrador duplicado	Dispensador con receta electrónica	Valida receta y stock sin redigitar	Medio	Dispensación electrónica
Personal de estadística	Digitador posterior	Analista de datos y calidad	Verifica y analiza la prestación generada	Alto	Calidad de datos y tablero
Dirección y Planeamiento	Usuario de reportes manuales	Usuario de tablero y evidencia	Decide con indicadores vigentes	Medio	Lectura de tablero y gobierno

2.5.5 Escenarios de negocio desarrollados

EB-02: consulta de la historia clínica por el médico tratante

Tabla 22
Escenario EB-02

Elemento	**Descripción**
Problema de negocio	El médico atiende con una historia física incompleta o con resultados que el paciente no trajo; no puede ver antecedentes, diagnósticos previos ni tratamientos en curso, y decide con información parcial.
Entorno	Consultorio de consulta externa, alta demanda, estaciones de trabajo de antigüedad variable y conectividad interna que puede fallar.
Actores	Médico, paciente, personal de enfermería, expediente clínico electrónico, servicio de identidad y auditoría.
Disparador	Inicio de la consulta.
Flujo esperado	1. El médico se autentica con su rol. 2. El sistema muestra la agenda del día. 3. El médico selecciona al paciente. 4. El sistema recupera el identificador único y muestra antecedentes, atenciones previas, diagnósticos, órdenes, resultados, prescripciones y alergias. 5. El médico registra la evolución y el diagnóstico. 6. El sistema audita el acceso y el cambio.
Resultado esperado	El médico cuenta con la información completa en una sola pantalla y registra la atención en el expediente, sin depender de documentos físicos.
Requisitos que ilustra	RQ-01, RQ-03, RQ-04; RD-01, RD-02, RD-03
Métrica de éxito	KPI-01: 95 % de consultas con registro completo a 24 meses; 100 % de accesos auditados (KPI-03).

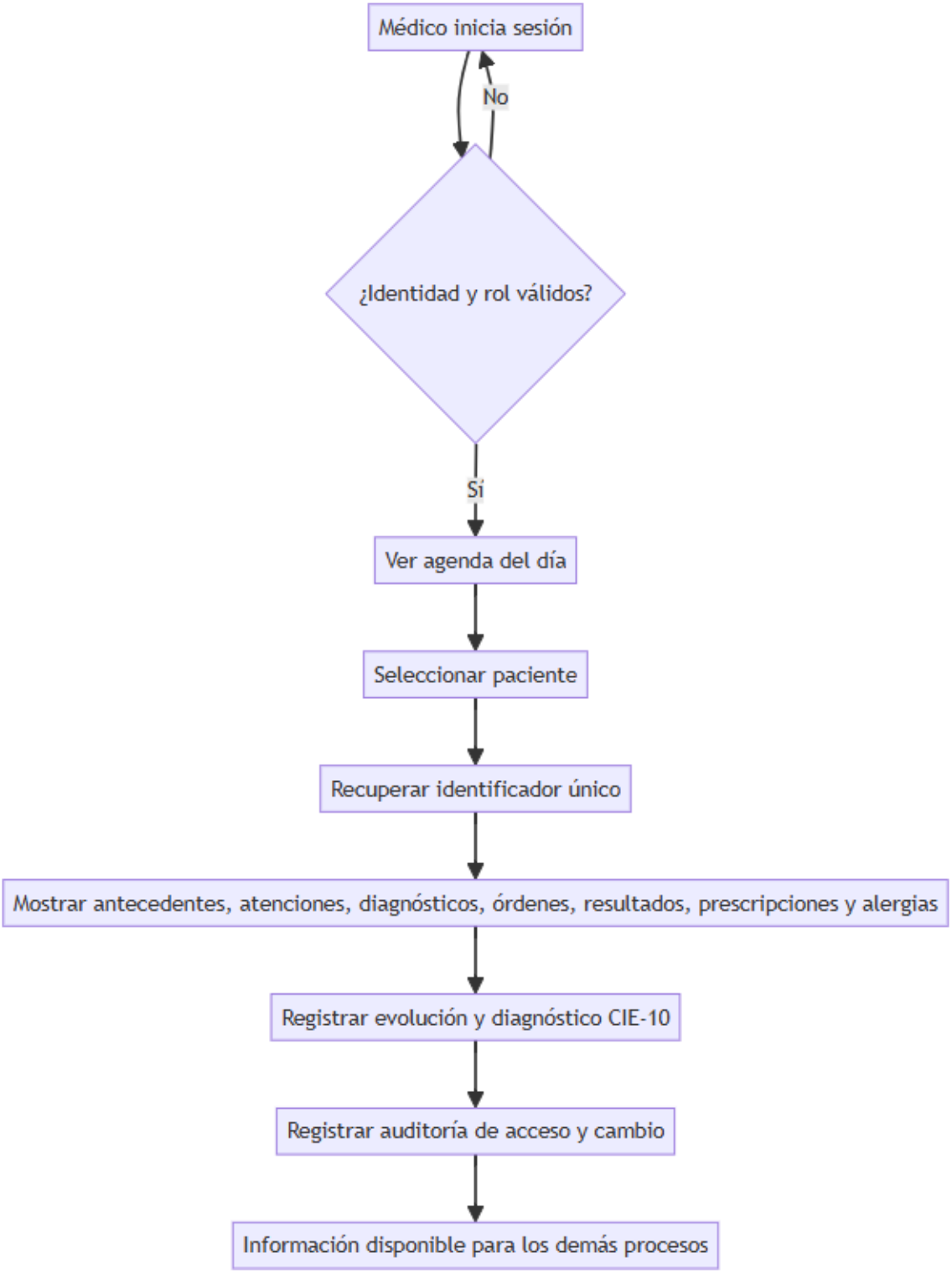


Figura 6

Flujo del escenario EB-02: consulta de la historia clínica

Nota. El flujo supone que el paciente ya tiene identificador único; si no lo tiene, se ejecuta primero el subflujo de identificación de P-02.

EB-03: registro y envío de la prestación de un asegurado al SIS

Tabla 23

Escenario EB-03

Elemento	Descripción
Problema de negocio	La prestación se digita después de la atención, a veces con datos incompletos o fuera del plazo; el hospital pierde financiamiento y el reporte sectorial no refleja la atención real.
Entorno	Oficina de estadística, aplicativo del SIS, conectividad externa limitada y cierre mensual de producción.
Actores	Personal de estadística, OSI, expediente clínico electrónico, servicio de interoperabilidad, SIS.
Disparador	Atención concluida y validada en el expediente.
Flujo esperado	1. El expediente genera el registro de la prestación con los datos de la atención. 2. Estadística valida consistencia y completitud. 3. El servicio de interoperabilidad envía la prestación al SIS. 4. El sistema registra el acuse o el error. 5. Si falla la conectividad, la prestación queda en cola y se reintenta. 6. El tablero refleja el estado del reporte.
Resultado esperado	La prestación se reporta completa y dentro del plazo, sin digitación posterior y con trazabilidad del envío.
Requisitos que ilustra	RQ-05, RQ-07; RD-05, RD-06; IF-07
Métrica de éxito	KPI-04: tres interfaces sectoriales operativas a 24 meses; porcentaje de prestaciones reportadas dentro del plazo.

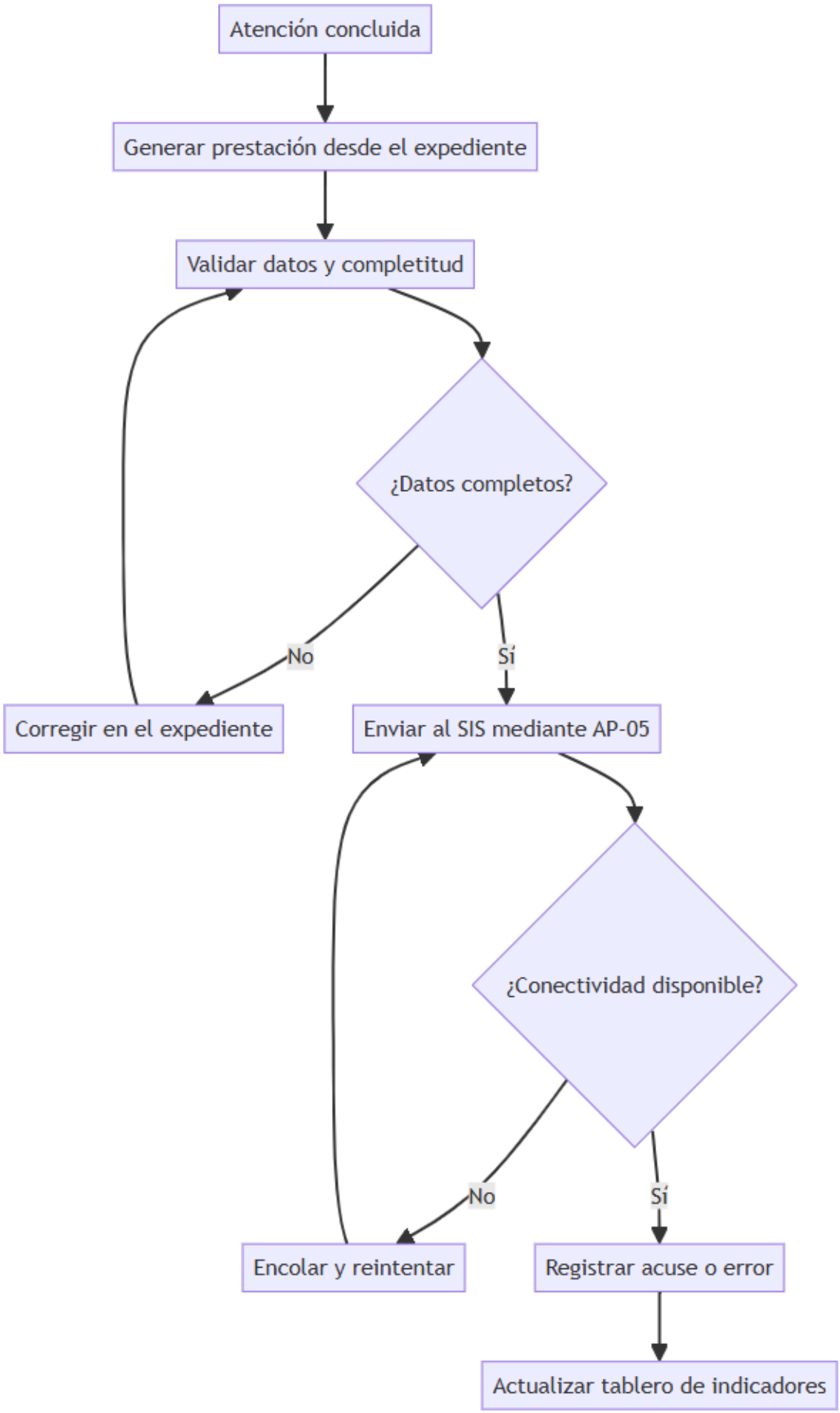

Atención concluida
Generar prestación desde el expediente
Validar datos y completitud
¿Datos completos?
No
Sí
Corregir en el expediente
Enviar al SIS mediante AP-05
¿Conectividad disponible?
No
Sí
Encolar y reintentar
Registrar acuse o error
Actualizar tablero de indicadores

Figura 7

Flujo del escenario EB-03: registro y envío de la prestación al SIS

Nota. El mecanismo concreto de intercambio del SIS debe verificarse con la entidad (S-F-03); el flujo es válido tanto para un servicio en línea como para una carga programada.

EB-01: proceso objetivo de consulta externa

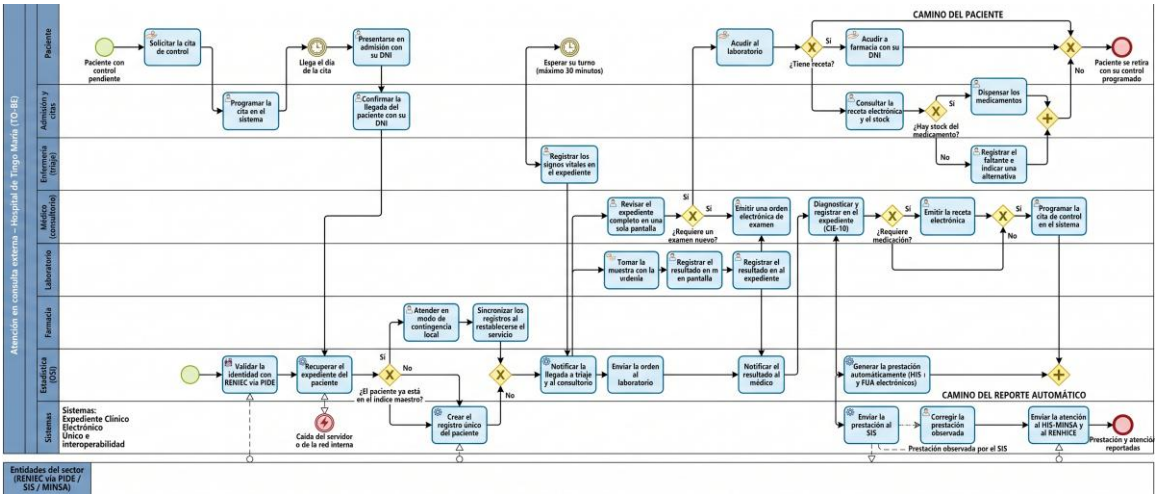


Figura 8

Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación objetivo (TO-BE)

Nota. Modelo BPMN 2.0 elaborado en Bizagi Modeler a partir de A-01, sección 12.4 y de los procesos P-01 a P-09 de la Tabla 20. Elaboración propia.

2.6 Vistas y puntos de vista

Las vistas de negocio responden a las preocupaciones de los interesados identificadas en A-01. En esta fase se elaboran las vistas PV-01 (recorrido del paciente), PV-07 (vista integrada) y PV-08 (gobierno y cumplimiento), y se dejan preparadas las vistas de datos, aplicaciones y tecnología para las Fases C y D.

Tabla 24

Vistas de negocio elaboradas

Código	Vista	Preocupación que responde	Interesados	Artefactos	Estado
PV-01	Recorrido del paciente	¿Cómo será la atención en consulta externa?	INT-01, INT-02, INT-05, INT-07	Figuras 2, 4 y 8; Tablas 16 y 20	Elaborada
PV-07	Vista integrada de negocio	¿Cómo encaja el negocio con los demás dominios?	INT-06, ARB	Figura 9; Tabla 19	Elaborada
PV-08	Gobierno y cumplimiento	¿Quién decide y cómo se demuestra el cumplimiento?	INT-06, INT-09, INT-14	Sección 2.3; capítulo 6; Tabla 14	Elaborada
PV-09	Capacidades y valor	¿Qué capacidades cambian y qué valor entregan?	INT-06, INT-09	Figura 5; Tablas 15 y 19	Elaborada

La Figura 9 presenta la vista integrada por capas, con el negocio como capa superior y las dependencias hacia datos, aplicaciones y tecnología que se resolverán en las fases siguientes.

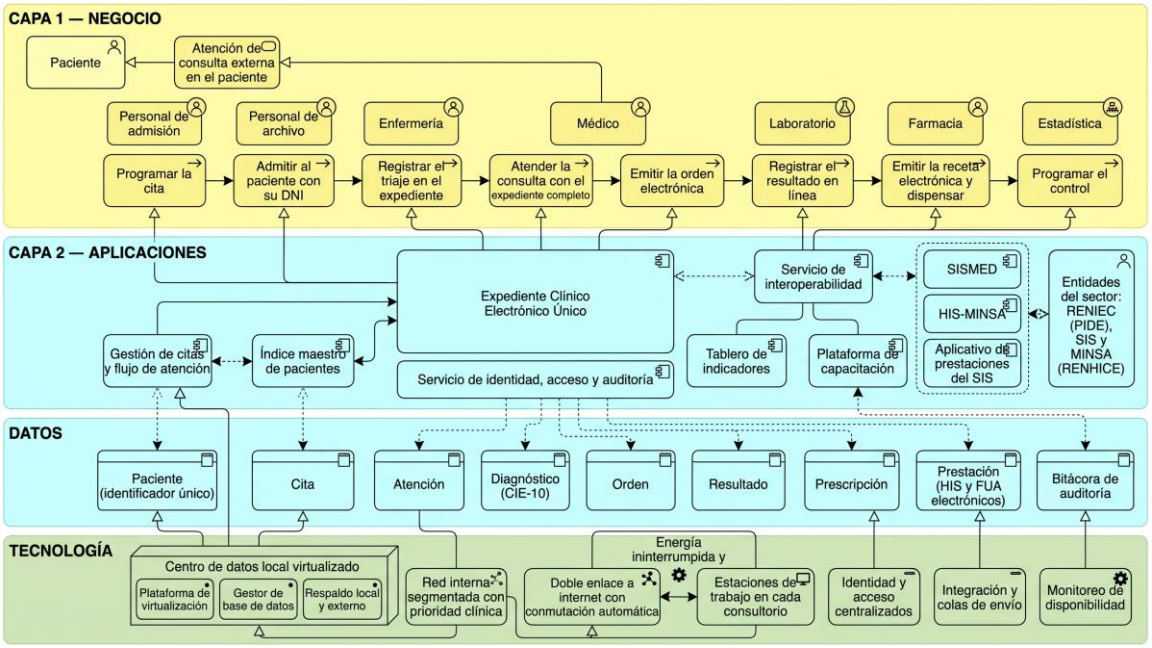


Figura 9

Vista integrada por capas de la arquitectura objetivo

Nota. Vista por capas en ArchiMate elaborada en Archi. La capa de negocio es la que se define en este documento; las capas de datos, aplicaciones y tecnología se detallan en C-01, C-02 y TEC-01. Elaboración propia.

---

3. Justificación y enfoque de la arquitectura

3.1 Racional de las decisiones de negocio

Las decisiones de arquitectura DA-01 a DA-06, formuladas en A-05, se reinterpretan aquí para el dominio de negocio. La tabla muestra qué implica cada decisión en procesos, roles y capacidades, y por qué se eligió frente a su alternativa.

Tabla 25

Decisiones de arquitectura y su efecto en el negocio

Código	Decisión	Alternativa descartada	Justificación desde el negocio	Efecto en procesos y roles	Principios
DA-01	El Expediente Clínico Electrónico Único es el eje de la arquitectura	Mejorar cada sistema por separado	La información clínica habilita a las demás capacidades; sin ella no se corrige la fragmentación (A-04, sección 3.3)	P-04 a P-09 se apoyan en una sola fuente; los roles registran en el expediente	PN-01, PN-02, PA-08
DA-02	Integrar los sistemas sectoriales en lugar de reemplazarlos	Reemplazar todos por una solución única	Los sistemas sectoriales son obligatorios o propiedad de otras entidades; reemplazarlos no es viable	P-08 se integra con el SIS y el sector; estadística valida en lugar de digitar	PA-06, PA-07
DA-03	Núcleo de la plataforma en un centro de datos local, con respaldo externo	Alojar todo en la nube	La conectividad limitada haría depender la atención de internet	Los procesos críticos operan en modo local y contingencia	PN-03, PA-02
DA-04	Uso de estándares abiertos (HL7 FHIR, DICOM, CIE-10)	Formatos propietarios del proveedor	Facilitan la interoperabilidad y evitan la dependencia de un solo proveedor	P-05, P-06 y P-08 usan estándares; el diagnóstico se codifica con CIE-10	PA-07
DA-05	Seguridad como servicio transversal y no por aplicación	Controles propios en cada sistema	Un único servicio de identidad y auditoría asegura el mismo nivel de protección	Todos los procesos acceden mediante AP-04; el acceso se audita	PN-04, PA-03, PA-04
DA-06	Implementación por estados de transición, empezando por la consulta externa	Implantación simultánea en todo el hospital	El presupuesto es cerrado y la preparación desaconseja un cambio total (A-04, sección 6)	Los procesos se despliegan por etapas; los roles se capacitan gradualmente	PA-02, PA-07

3.2 Enfoque

La arquitectura de negocio se elaboró con el siguiente enfoque:

16. **Método.** Se aplicaron los pasos 1 a 9 de la Fase B de TOGAF 9.1: selección de modelos de referencia, descripción de la línea base, descripción de la arquitectura objetivo, análisis de brechas, definición de componentes candidatos, evaluación de impactos y validación con interesados.
17. **Lenguaje.** Los procesos se modelaron en BPMN 2.0 y las capacidades y vistas en ArchiMate 3.1, para asegurar consistencia con A-01 y A-05.
18. **Fuentes.** Se usaron la Petición D-06, los entregables A-01 a A-05, las entrevistas con jefaturas médicas, la observación de la atención y la normativa sectorial vigente.
19. **Validación.** Cada meta, objetivo, principio y proceso se validó con al menos un responsable de negocio. Las actas se registran en el Apéndice C. Las observaciones no bloqueantes se incorporaron o se registraron como pendientes.
20. **Límites.** No se accedió a historias clínicas ni a datos personales identificables. Las mediciones de tiempo y completitud se realizaron con la Dirección Asistencial mediante observación agregada y auditoría de una muestra, sin copiar datos de pacientes.
21. **Trazabilidad.** Cada elemento de la arquitectura de negocio se vincula con una meta, un principio, un objetivo, una capacidad, un proceso y un requisito, según la matriz del Apéndice B.

El enfoque es incremental: esta versión 1.0 cierra el negocio de la consulta externa y deja preparadas las extensiones a hospitalización y emergencia para la siguiente iteración.

---

4. Correspondencia con el Repositorio de Arquitectura

4.1 Correspondencia con el panorama de arquitectura

Tabla 26
Ubicación de los contenidos de B-01 en el Repositorio

Sección del Repositorio (TOGAF 9.1)	Contenido aportado por B-01	Versión	Estado
Panorama de la arquitectura (*Architecture Landscape*)	Arquitectura de negocio base y objetivo de la consulta externa	1.0	Aprobado como borrador para el Hito H2

Sección del Repositorio (TOGAF 9.1)	Contenido aportado por B-01	Versión	Estado
Modelos de referencia	Cadena de valor, mapa de capacidades, procesos P-01 a P-09	1.0	Publicado
Base de información de estándares	Estándares de negocio, interoperabilidad y codificación	1.0	Publicado
Registro de gobierno	Decisiones DA-01 a DA-06 aplicadas al negocio	1.0	A registrar en GV-01
Requisitos	Requisitos de negocio refinados y su trazabilidad	1.0	A registrar en GR-01
Biblioteca de bloques de construcción	ABB BB-01 a BB-08 y componentes candidatos	1.0	Publicado

4.2 Correspondencia con modelos de referencia

Tabla 27
Modelos de referencia utilizados

Modelo de referencia	Uso en B-01	Grado de adopción	Observación
TOGAF 9.1, Fase B	Guía de pasos, artefactos y contenido mínimo	Total	Marco metodológico del proyecto
ArchiMate 3.1	Modelado de capacidades, actores y vistas	Total	Usado en Archi
BPMN 2.0	Modelado de procesos EB-01, EB-02 y EB-03	Total	Usado en Bizagi Modeler
Modelo de Referencia Técnica de TOGAF	Clasificación de servicios tecnológicos dependientes	Parcial	Se detalla en TEC-01
Modelos sectoriales del MINSA	Estándares de historia clínica e interoperabilidad	Parcial	Sujetos a verificación con el MINSA
Cadena de valor genérica de Porter	Adaptación al recorrido del paciente	Adaptada	No se usa como modelo normativo

4.3 Correspondencia con estándares

Tabla 28

Estándares aplicables a la arquitectura de negocio

Estándar	Versión o referencia	Ámbito	Fuente	Estado
HL7 FHIR	R4 (2019)	Interoperabilidad clínica	HL7 International	Adoptado como opción preferente
DICOM	Vigente	Imágenes médicas	DICOM Standards Committee	Adoptado
CIE-10	Décima revisión	Codificación de diagnósticos	Organización Mundial de la Salud	Adoptado
NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN	2018	Gestión de la historia clínica	Ministerio de Salud	Obligatorio
RENHICE	Ley N.° 30024 (2013)	Registro nacional de historias clínicas electrónicas	Congreso de la República	Obligatorio
Ley N.° 29733	2011	Protección de datos personales	Congreso de la República	Obligatorio
ISO 8601	Vigente	Representación de fechas y horas	ISO	Adoptado
BPMN 2.0	2011	Modelado de procesos	Object Management Group	Adoptado
ArchiMate	3.1 (2019)	Modelado de arquitectura	The Open Group	Adoptado

4.4 Evaluación de reutilización

Tabla 29
Elementos reutilizables de la Fase A y su tratamiento

Elemento	Origen	Reutilización en B-01	Decisión
Metas BG-001 a BG-004	A-01, Tabla 12	Se validan y se mantienen	Reutilizar sin cambios
Objetivos OA-01 a OA-07	A-01, Tabla 27	Se validan y se precisan con SMART	Reutilizar con precisión
Impulsores IC-01 a IC-09	A-01, Tabla 16	Se validan y se clasifican	Reutilizar sin cambios
Principios PA-01 a PA-08	A-01, Tabla 17	Se elaboran para negocio	Reutilizar y elaborar
Capacidades CB-01 a CB-10	A-04, Tabla 10	Se usan como línea base y objetivo	Reutilizar
Procesos P-01 a P-09	A-05, Tabla 9	Se detallan en AS-IS y TO-BE	Reutilizar y detallar
Escenario EB-01	A-01, sección 12	Se valida con jefaturas	Reutilizar
Brechas BR-01 a BR-08	A-04, Tabla 21	Se agrupan por categoría de negocio	Reutilizar
ABB BB-01 a BB-08	A-05, Tabla 30	Se usan para componentes candidatos	Reutilizar
Estados TA-1 a TA-4	A-05, Tabla 29	Se detallan en la vista de negocio	Reutilizar y detallar

---

5. Análisis de brechas

5.1 Brechas de negocio por categoría

El análisis de brechas de la Fase B profundiza el de A-04 y lo organiza según las categorías que TOGAF recomienda revisar para no olvidar ninguna dimensión del negocio (The Open Group, 2011, cap. 27).

Tabla 30

Brechas de negocio por categoría

Categoría	Brecha	Evidencia	Impacto en el negocio	Brecha relacionada
Personas	El personal clínico no dispone de tiempo protegido ni de acompañamiento para adoptar el registro electrónico	A-04, F-11; R-A-01	La adopción sería parcial y el registro quedaría incompleto	BR-02, BR-03
Personas	Los roles de archivo y digitación no están rediseñados para la operación electrónica	A-05, Tabla 8; Tabla 17	Duplicidad de funciones y resistencia al cambio	BR-02
Procesos	La admisión, la consulta y la farmacia operan como procesos aislados	Tabla 16	El paciente repite trámites y la información se fragmenta	BR-02
Procesos	No existe un procedimiento de contingencia documentado para la atención sin sistema	CN-B-01; PA-02	Riesgo de interrupción de la atención	BR-04
Herramientas	No hay una herramienta única de historia clínica ni agenda integrada	A-05, Tabla 16	Registros duplicados y búsqueda manual	BR-02, BR-06
Información	No existe identificador único de paciente ni dueños de datos	A-05, Tabla 12; RD-07	Duplicados y decisiones con información incompleta	BR-02, BR-06
Información	No hay clasificación de sensibilidad ni reglas de calidad	A-05, Tabla 13 y 15	Riesgo de acceso indebido y datos no confiables	BR-01
Medición	Los tiempos de espera y la completitud del registro no se miden	KPI-01, KPI-02	No se puede demostrar mejora ni priorizar	BR-08
Medición	Los indicadores estratégicos se consolidan manualmente	A-04, Tabla 10 (CB-09)	Decisiones sin datos vigentes	BR-08
Financiamiento	No hay partida recurrente para la función de arquitectura ni para la operación	A-04, F-04, F-05; BR-07	La arquitectura no se sostiene después del proyecto	BR-07
Instalaciones	No hay un espacio adecuado para el centro de datos local ni protección eléctrica suficiente	A-05, S-F-04; Tabla 20	Riesgo para la continuidad	BR-04

5.2 Matriz de brechas entre la línea base y el objetivo

Tabla 31

Matriz de cambios entre la arquitectura base y la objetivo

Elemento	Línea base	Objetivo	Tratamiento	Brecha	Requisito	Prioridad
Programación de citas	Turnos por orden de llegada	Citas programadas por especialidad y canal	Reemplazar	BR-02	RQ-02, RQ-09	Alta
Admisión	Búsqueda de historia física y registro manual	Identificación única y admisión en el sistema	Reemplazar	BR-02	RQ-02	Alta
Triaje	Registro en papel	Registro directo en el expediente	Reemplazar	BR-02	RQ-01	Alta
Consulta	Historia física incompleta	Expediente completo en una pantalla	Modificar	BR-02	RQ-01	Alta
Órdenes y resultados	Papel trasladado por el paciente	Orden y resultado en línea	Reemplazar	BR-02	RQ-01, RQ-07	Alta
Prescripción y dispensación	Receta manuscrita y redigitación	Receta electrónica y dispensación validada	Reemplazar	BR-02	RQ-01, RQ-05	Alta
Registro de prestación	Digitación posterior	Generación automática y envío al SIS	Reemplazar	BR-08	RQ-05, RQ-07	Alta
Seguimiento	Agenda manual	Cita de control generada desde la consulta	Modificar	BR-02	RQ-01, RQ-02	Media
Rol de archivo	Custodio de la historia física	Apoyo a digitalización y gestión documental	Modificar	BR-02	RQ-08	Media
Indicadores	Consolidación manual	Tablero con datos vigentes	Reemplazar	BR-08	RQ-06	Media
Contingencia	Procedimiento informal	Procedimiento documentado y probado	Nuevo	BR-04	RQ-04	Alta

Nota. Los requisitos RQ-09 y siguientes se definen en B-02, sección 3.1, como refinamiento de los requisitos de interesados de A-01.

5.3 Priorización de brechas

Tabla 32

Priorización de las brechas de negocio

Orden	Brecha	Impacto en la misión	Urgencia	Dependencias	Prioridad	Fase de resolución
1	BR-05 Función de arquitectura y gobierno	Todos los verbos	Bloquea la aprobación y el control del cambio	Todas	Crítica	A, B y G
2	BR-02 Atención no centrada en el paciente	Recuperar, rehabilitar	Eje de la Fase B	BR-03	Alta	B y C
3	BR-08 Vigencia de la planificación e indicadores	Prevenir	Bloquea la medición de objetivos	BR-02	Alta	A y B
4	BR-06 Inventario de sistemas e infraestructura	Todos los verbos	Bloquea las Fases C y D	BR-01, BR-03, BR-04	Alta	C y D
5	BR-01 Seguridad de la información	Proteger	Requisito de la Fase C	—	Alta	C y D
6	BR-04 Infraestructura y OSI	Todos los verbos	Requisito de las Fases D a F	—	Alta	D, E y F
7	BR-03 Usabilidad	Recuperar	Requisito de la Fase C	—	Media	B, C y G
8	BR-07 Financiamiento recurrente	Todos los verbos	Requisito de las Fases F y G	—	Media	F y G

Nota. La priorización conserva el orden de A-04 y añade la dependencia explícita de BR-02 respecto de BR-05: sin gobierno, el rediseño de la atención no se sostiene.

---

6. Impacto en el panorama de arquitectura

6.1 Impacto en las arquitecturas preexistentes

Tabla 33
Impacto sobre las arquitecturas existentes

Arquitectura o elemento	Impacto	Intensidad	Respuesta
Procesos de consulta externa	Rediseño de P-01 a P-09 y de sus roles	Alta	Validación con jefaturas y despliegue por etapas
Historia clínica en papel	Coexistencia durante la transición; conservación según la NTS N.° 139	Alta	Digitalización gradual y custodia de la historia física
Sistemas sectoriales (APB-01 a APB-07)	Se mantienen y se integran; no se reemplazan	Media	Interfaces mediante AP-05
Sistema del proveedor actual (APB-08)	Posible cambio de alcance o reemplazo	Media	Evaluación en la Fase E; cláusulas de salida
Procesos de archivo y estadística	Cambio de funciones y de carga de trabajo	Alta	Redefinición de roles y capacitación
Indicadores del Plan Operativo	Cambio de fuente y de frecuencia	Media	Modelo de indicadores en B-02 y C-01

6.2 Cambios recientes que afectan la arquitectura de negocio

Tabla 34
Cambios recientes y su efecto

Cambio	Fecha o vigencia	Efecto en la arquitectura de negocio	Respuesta
Obligación de alinearse al RENHICE	Vigente	El expediente debe cumplir el marco nacional	Requisito RD-06 y estándar NTS N.° 139
Obligaciones de gobierno digital e interoperabilidad	Vigente	Nuevas expectativas de servicios digitales y datos abiertos	Incorporadas en IC-02 y RQ-07
Protección reforzada de datos sensibles	Vigente	Acceso restringido y auditoría obligatoria	PN-04, PA-03 y PA-04
Cambios en el financiamiento del SIS	Vigente	El registro completo condiciona el financiamiento	P-08 y KPI-04
Rotación de personal clínico	Continua	Pérdida de conocimiento y necesidad de capacitación	KPI-06 y plan de capacitación

6.3 Oportunidades

Tabla 35
Oportunidades identificadas

Oportunidad	Descripción	Beneficio	Condición
Reutilizar el índice maestro para toda la hospitalización futura	El identificador único sirve a todas las iteraciones	Evita duplicados y acelera la extensión	Aprobar BB-02 en la Fase C
Integrar los sistemas sectoriales en lugar de reemplazarlos	Menor costo y menor riesgo contractual	Conserva la inversión existente	Acuerdos técnicos con MINSA y SIS
Aprovechar la plataforma de capacitación para la adopción	Formación medible y registro de horas	Reduce la resistencia al cambio	Aprobar BB-07 y el plan de capacitación

Oportunidad	Descripción	Beneficio	Condición
Usar el tablero para el seguimiento del Plan Operativo	Indicadores con datos vigentes	Mejora la decisión y el cumplimiento	Confirmar la vigencia del instrumento (S-A-01)
Documentar el procedimiento de contingencia como activo reutilizable	Sirve para todas las áreas y turnos	Reduce el riesgo de interrupción	Validarlo con la Dirección Asistencial

6.4 Impacto en otros proyectos

Tabla 36
Relación con otros proyectos e iniciativas

Proyecto o iniciativa	Relación	Impacto	Coordinación
Inventario de aplicaciones e infraestructura	Insumo de las Fases C y D	Alto	Enlace de la OSI; semanas 11 a 16
Adquisición o ampliación del sistema del proveedor	Alternativa de solución para AP-01 y AP-02	Alto	Fase E; cláusulas de arquitectura
Programa de capacitación del personal	Habilita la adopción del expediente	Medio	Recursos Humanos y A-03
Proyectos de infraestructura eléctrica y de conectividad	Sostienen la continuidad	Alto	Dirección de Administración y OSI
Iniciativas de gobierno digital regional	Condicionan la interoperabilidad	Medio	DIRESA y MINSA

---

7. Arquitectura de transición

7.1 Definición de los estados de transición

Los estados de transición describen configuraciones intermedias y arquitectónicamente significativas entre la línea base y la arquitectura objetivo. Se mantienen los cuatro estados propuestos en A-05 y se detallan en su dimensión de negocio. No incluyen fechas de ejecución: su planificación corresponde a las Fases E y F.

Tabla 37

Estados de transición y su contenido de negocio

Estado	Nombre	Capacidades que se habilitan	Procesos que cambian	Requisitos previos	Valor para el negocio
TA-1	Fundamentos	CB-05, CB-06, CB-07 (base), CB-02 (identificación)	P-02 con identificador único; P-08 con mecanismo de envío	Aprobación de la hoja de ruta y financiamiento de la primera etapa	Base segura, identificación única y gobierno operativo
TA-2	Piloto de consulta externa	CB-01, CB-02, CB-07, CB-08	P-01 a P-07 en una especialidad piloto	TA-1; pruebas de usabilidad; contingencia probada	Evidencia real de reducción de tiempos y completitud
TA-3	Consulta externa completa	CB-01 a CB-10 (excepto CB-03)	P-01 a P-09 en todas las especialidades	Resultados del piloto aprobados por el ARB; acuerdos sectoriales	Cumplimiento de KPI-01, KPI-02 y KPI-04
TA-4	Siguiente iteración	Extensión a hospitalización y emergencia	Procesos de hospitalización y emergencia	Nuevo ciclo del ADM	Continuidad del cuidado en todo el hospital

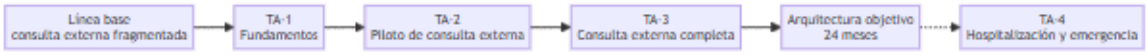


Figura 10

Secuencia de los estados de transición

Nota. Cada estado incluye coexistencia con el proceso anterior y un mecanismo de reversión, conforme a PN-03 y PA-02.

7.2 Arquitectura de negocio por estado de transición

Tabla 38

Detalle de negocio por estado de transición

Estado	Capacidades	Procesos	Roles	Nivel de servicio	Criterio de salida
TA-1	CB-05, CB-06, CB-07, CB-02	P-02, P-08	Admisión, archivo, estadística, OSI	Identificación única y envío sectorial básico	Índice maestro depurado; identidad y auditoría operativas; inventario completo
TA-2	CB-01, CB-02, CB-07, CB-08	P-01 a P-07 en piloto	Médicos, enfermería, laboratorio, farmacia, admisión	Tiempo de admisión y consulta medido; registro completo	Piloto evaluado; usabilidad aprobada; contingencia probada
TA-3	CB-01 a CB-10	P-01 a P-09 en todas las especialidades	Todos los roles de la cadena	KPI-01, KPI-02 y KPI-04 en seguimiento	Metas de KPI alcanzadas o plan de corrección aprobado
TA-4	Todas	Hospitalización y emergencia	Roles clínicos ampliados	Según el nuevo ciclo del ADM	Arquitectura de la siguiente iteración aprobada

7.3 Dependencias de datos, aplicaciones y tecnología por estado

Tabla 39

Dependencias de los estados de transición con las Fases C, D y E

Estado	Datos	Aplicaciones	Tecnología	Entregable que lo habilita
TA-1	Índice maestro y datos maestros depurados	AP-03, AP-04, AP-05	Identidad, red segmentada, energía protegida, respaldo	C-01, C-02, TEC-01
TA-2	Modelo lógico del expediente; clasificación de sensibilidad	AP-01, AP-02, AP-03, AP-04, AP-05	Centro de datos local, estaciones de trabajo, contingencia	C-01, C-02, C-03, TEC-01
TA-3	Datos de todas las especialidades; calidad medida	AP-01 a AP-07; interfaces IF-01 a IF-09	Conectividad redundante, monitoreo, capacidad	C-01, C-02, C-03, TEC-01, TEC-02
TA-4	Datos de hospitalización y emergencia	Ampliación del expediente y de la interoperabilidad	Ampliación de plataforma	Nuevo ciclo del ADM

Nota. Este documento no decide las soluciones de datos, aplicaciones ni tecnología; solo establece las dependencias que las Fases C y D deben resolver para que cada estado sea viable.

---

8. Componentes candidatos del Plan de Itinerario

8.1 Componentes candidatos de la arquitectura de negocio

Los componentes candidatos son las unidades de cambio que el negocio necesita para pasar de la línea base a la arquitectura objetivo. No son proyectos aprobados ni compras: son insumos para que las Fases E y F construyan los paquetes de trabajo y la hoja de ruta.

Tabla 40

Componentes candidatos del Plan de Itinerario

Código	Componente	ABB	Descripción	Dependencias	Valor para el negocio	Estado de transición	Prioridad
R-B-01	Gobierno y función de arquitectura	—	Formalizar la función, instalar el ARB y operar el procedimiento de cambio	Decisión de la Dirección; A-02	Sostiene todas las decisiones y evita compras aisladas	TA-1	Crítica
R-B-02	Rediseño de la cadena de consulta externa	BB-01, BB-03	Rediseñar P-01 a P-09 con participación clínica y validar el proceso objetivo	R-B-01, R-B-03, R-B-04	Elimina la repetición de trámites y reduce tiempos	TA-2 y TA-3	Alta
R-B-03	Identificación única y depuración de pacientes	BB-02	Implantar el índice maestro y depurar duplicados	R-B-01; C-01	Base para el expediente único y la seguridad del paciente	TA-1	Alta
R-B-04	Citas y flujo de atención	BB-03	Implantar agenda por especialidad y medición de tiempos por etapa	R-B-03; C-02	Reduce esperas y permite gestionar la demanda	TA-1 y TA-2	Alta
R-B-05	Registro clínico único y adopción	BB-01	Implantar el expediente y acompañar su adopción por el personal	R-B-03; C-01, C-02	Información completa y registro único	TA-2 y TA-3	Alta
R-B-06	Órdenes y resultados en línea	BB-01	Integrar órdenes y resultados de laboratorio e imágenes	R-B-05; IF-08	Elimina el traslado de documentos y acelera la decisión	TA-2 y TA-3	Alta
R-B-07	Prescripción electrónica y dispensación	BB-01	Receta electrónica con validación de catálogo y stock	R-B-05; IF-09	Reduce errores y redigitación en farmacia	TA-3	Media
R-B-08	Registro y reporte de prestaciones	BB-05	Generar la prestación desde la atención y enviarla al SIS	R-B-05; IF-07	Asegura el financiamiento y el reporte oportuno	TA-3	Alta
R-B-09	Tablero de indicadores y calidad de datos	BB-06	Modelar indicadores, fuentes y reglas de calidad	R-B-05; C-01	Decisiones con datos vigentes	TA-3	Media
R-B-10	Capacitación y gestión del cambio	BB-07	Plan de formación y registro de horas por profesional	R-B-05; Recursos Humanos	Adopción sostenible y cumplimiento de KPI-06	TA-1 a TA-3	Media

Nota. Los componentes R-B-01 a R-B-10 se ordenan por dependencia, no por fecha. La Fase E evaluará su agrupación en paquetes de trabajo y la Fase F los priorizará por valor y riesgo.

8.2 Catálogo de factores de implementación

Tabla 41

Factores que condicionan la implementación

Código	Tipo	Descripción	Impacto	Responsable
FI-01	Riesgo	Resistencia del personal clínico al registro electrónico	Alto	Dirección Asistencial
FI-02	Riesgo	Cortes de energía o conectividad durante la atención	Alto	OSI
FI-03	Riesgo	Duplicados y errores en los datos de pacientes	Alto	OSI
FI-04	Supuesto	El instrumento de planificación estratégica está vigente (S-A-01)	Alto	Planeamiento y Presupuesto
FI-05	Supuesto	El MINSA y el SIS ofrecen mecanismos documentados de intercambio (S-F-03)	Alto	OSI
FI-06	Dependencia	Inventario de aplicaciones e infraestructura (BR-06)	Crítico	OSI
FI-07	Dependencia	Aprobación de la arquitectura de datos y aplicaciones (C-01, C-02)	Alto	ARB
FI-08	Dependencia	Financiamiento de la primera etapa (TA-1)	Crítico	Planeamiento y Presupuesto
FI-09	Acción	Validar el proceso objetivo con al menos dos jefaturas médicas	Alto	Dirección Asistencial
FI-10	Acción	Medir la línea base de KPI-01 y KPI-02 antes de implementar	Alto	Dirección Asistencial
FI-11	Entrada	Petición D-06 y actas de validación de EB-01, EB-02 y EB-03	Medio	Arquitecto de negocio
FI-12	Entrada	Normativa vigente del RENHICE y de protección de datos	Alto	Arquitecto líder

8.3 Matriz consolidada de brechas, soluciones y dependencias

Tabla 42
Matriz de brechas, soluciones y dependencias

Brecha	Solución propuesta	Dependencias	Componente
BR-01 Seguridad no institucionalizada	Identidad, acceso por rol y auditoría	AP-04; C-01; TEC-01	R-B-01, R-B-03
BR-02 Atención no centrada en el paciente	Rediseño de la cadena y expediente único	R-B-01, R-B-03, R-B-04, R-B-05	R-B-02
BR-03 Baja usabilidad	Pruebas de usabilidad y diseño centrado en el trabajo clínico	R-B-05; R-B-10	R-B-05, R-B-10
BR-04 Infraestructura y OSI	Plataforma resiliente y fortalecimiento de la OSI	TEC-01; E-01; F-01	R-B-01, R-B-05
BR-05 Función de arquitectura	Formalización y ARB operativo	Decisión de la Dirección	R-B-01
BR-06 Inventario	Levantamiento de aplicaciones e infraestructura	Enlace de la OSI	R-B-01
BR-07 Financiamiento recurrente	Caso de negocio y partida en el modelo de gobierno	F-01; G-01	R-B-01, R-B-02
BR-08 Planificación e indicadores	Confirmación del instrumento y tablero	S-A-01; C-01	R-B-09

8.4 Recomendaciones de implementación

Tabla 43
Recomendaciones para las Fases E y F

Recomendación	Justificación	Condición	Responsable
Agrupar R-B-01, R-B-03 y R-B-04 en la primera etapa	Crean la base de gobierno, identidad y citas sin la cual el expediente no funciona	Aprobación de la hoja de ruta y financiamiento	Arquitecto líder
No iniciar el piloto del expediente sin pruebas de usabilidad aprobadas	La adopción es el principal riesgo del negocio (PA-05)	Acta de pruebas y plan de contingencia	Dirección Asistencial
Tratar la contingencia como parte del piloto, no como un anexo	La continuidad es un principio de negocio (PN-03)	Procedimiento documentado y probado	OSI
Medir KPI-01 y KPI-02 antes de la primera implantación	Sin línea base no se puede demostrar valor	Medición en las semanas 9 y 10	Dirección Asistencial
Incluir la capacitación en cada paquete de trabajo	La adopción no ocurre por sí sola	Plan de capacitación aprobado	Recursos Humanos
Reservar una revisión del ARB al cierre de cada estado	Permite corregir antes de escalar	Calendario del ARB	Secretario del ARB

---

9. Actualización de la Declaración de Trabajo de Arquitectura

9.1 Evaluación de la necesidad de actualización

La Guía de Bolsillo indica que la Declaración de Trabajo se actualiza si fuera necesario al completar la Fase B. Se evaluaron los cinco disparadores previstos en el procedimiento de cambio de A-02, sección 9.

Tabla 44
Evaluación de los disparadores de actualización de A-02

Disparador	¿Cambió?	Evidencia	Conclusión
Alcance	No	El alcance de B-01 coincide con A-02, sección 6.2 y con la Tabla 7 de este documento	Sin cambio
Objetivos	No	OA-01 a OA-07 se mantienen; solo se precisan con SMART en la Tabla 9	Sin cambio sustantivo
Entregables	No	B-01 y B-02 son los entregables comprometidos en A-02, Tabla 18	Sin cambio
Plazo	No	El cierre se mantiene en la semana 12 (Hito H2)	Sin cambio
Presupuesto	No	No se solicitan recursos adicionales para la Fase B	Sin cambio

La evaluación concluye que no existe un cambio de alcance, objetivos, entregables, plazo ni presupuesto que requiera una solicitud de cambio (SC). Sin embargo, la Declaración debe registrar el avance del proyecto y el estado de las condiciones previas, por lo que se emite una actualización menor de estado.

9.2 Contenido de la actualización menor

Tabla 45
Cambios incorporados en A-02 v2.1

Sección de A-02	Cambio	Motivo
Historial de versiones	Nueva fila 2.1 con fecha 05/11/2026	Registrar el cierre de la Fase B y la presentación de B-01 y B-02
Información de seguimiento	Versión 2.1 (actualización de estado al cierre de la Fase B)	Reflejar la versión vigente
Sección 10.2, nota posterior a la Tabla 18	B-01 y B-02 entregados para aprobación del ARB	Trazabilidad del avance
Sección 12.3, Tabla 23	Hito H2: B-01 y B-02 presentados al ARB	Seguimiento del cronograma
Sección 13, Tabla 24	Estado de las condiciones previas actualizado al cierre de la Fase B	Gobierno del proyecto

Nota. La actualización es de nivel menor conforme a A-02, Tabla 16, y la decide el Comité de Seguimiento. No requiere solicitud de cambio porque no altera el alcance, los objetivos, los entregables, el plazo ni el presupuesto.

9.3 Registro y comunicación

22. El arquitecto líder presenta la evaluación al Comité de Seguimiento en la semana 11.

23. El Comité aprueba la actualización menor y la registra en el acta correspondiente.

24. El Administrador del Repositorio publica A-02 v2.1 sin sobrescribir la versión 2.0.
25. La actualización se comunica al ARB y a los interesados de la lista de distribución de A-02.
26. La decisión se registra en GV-01 con el código de acta del Comité.

---

10. Supuestos y riesgos de la arquitectura de negocio

10.1 Supuestos

Tabla 46

Supuestos de la arquitectura de negocio

Código	Supuesto	Valida	Fecha objetivo	Estado
S-B-01	Las metas BG-001 a BG-004 y los objetivos OA-01 a OA-07 siguen vigentes al cierre de la Fase B	Dirección Ejecutiva y Planeamiento	Semana 12	Confirmado (Tablas 8 y 9)
S-B-02	Las jefaturas médicas participan en la validación del proceso objetivo	Dirección Asistencial	Semana 11	Confirmado (Apéndice C)
S-B-03	La línea base de KPI-01 y KPI-02 se completa en la semana 10	Dirección Asistencial	Semana 10	En proceso
S-B-04	El instrumento de planificación estratégica está vigente (S-A-01)	Planeamiento y Presupuesto	Semana 12	Pendiente
S-B-05	Los sistemas sectoriales se mantienen y pueden integrarse (S-F-01, S-F-03)	OSI	Semana 13	Pendiente
S-B-06	El hospital dispone de un espacio adecuado para el centro de datos local (S-F-04)	Dirección de Administración	Semana 16	Pendiente
S-B-07	El personal clínico dispone de tiempo protegido para capacitación	Dirección Asistencial y Recursos Humanos	Semana 12	Pendiente
S-B-08	No se modificará el alcance de la primera iteración durante la Fase B	Patrocinador y ARB	Semana 12	Confirmado por acta del ARB

10.2 Riesgos

Tabla 47

Riesgos de la arquitectura de negocio

Código	Riesgo	Categoría	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-B-01	El proceso objetivo no se valida con las jefaturas y se aprueba solo en el papel	Gobierno	Alto	Talleres de validación y actas; participación de al menos dos jefaturas	Bajo	Dirección Asistencial
R-B-02	La línea base de KPI-01 y KPI-02 no se mide y no se puede demostrar la mejora	Medición	Alto	Medición programada en la semana 10; responsable designado	Bajo	Dirección Asistencial
R-B-03	El rediseño de roles de archivo y estadística genera resistencia	Personas	Alto	Redefinición con Recursos Humanos; comunicación y capacitación	Medio	Dirección de Administración
R-B-04	La arquitectura de negocio no se sostiene porque el financiamiento no se aprueba	Financiero	Alto	Caso de negocio en la Fase F; implementación por etapas	Medio	Planeamiento y Presupuesto
R-B-05	El instrumento de planificación no está vigente y los objetivos pierden referencia	Estratégico	Alto	Confirmación antes de la semana 12; registrar como supuesto	Medio	Planeamiento y Presupuesto
R-B-06	Los sistemas sectoriales no permiten la integración prevista	Externo	Medio	Verificación temprana; mecanismos alternativos de carga	Medio	OSI
R-B-07	El expediente no se adopta por baja usabilidad	Personas y tecnología	Alto	Pruebas de usabilidad; diseño centrado en el trabajo clínico	Medio	Dirección Asistencial
R-B-08	La información de salud se expone durante las validaciones	Legal	Medio	Solo datos agregados o anonimizados; acuerdo de confidencialidad	Bajo	Arquitecto líder
R-B-09	El alcance crece con nuevas solicitudes durante la Fase B	Proyecto	Medio	Aplicación del procedimiento de cambio de A-02	Bajo	Arquitecto líder
R-B-10	La rotación de personal pierde el conocimiento adquirido	Personas	Medio	Documentación en el Repositorio; transferencia de conocimiento	Bajo	Recursos Humanos

---

11. Conclusiones

27. La arquitectura de negocio confirma que el problema del hospital no es la falta de un sistema, sino la fragmentación de la información y de los procesos. El expediente único y la identificación única son las palancas que habilitan las demás mejoras.
28. Las metas, objetivos, motivaciones y principios de la Fase A siguen vigentes. Se añaden cinco principios de negocio (PN-01 a PN-05) que traducen la misión y las metas en reglas verificables para los procesos y los roles.
29. La línea base muestra procesos aislados, registros en papel, tiempos no medidos y una farmacia que redigita la prescripción. La arquitectura objetivo reorganiza la cadena de valor, mide los tiempos por etapa y genera la prestación desde la atención.
30. Los escenarios EB-02 y EB-03 se desarrollaron y se vincularon con requisitos, interfaces y KPI. EB-04 queda como dependencia de la Fase D y del principio de continuidad.
31. Las brechas de negocio se agruparon en siete categorías y se priorizaron. Las más críticas son el gobierno de la arquitectura (BR-05), la fragmentación de la atención (BR-02) y la medición (BR-08).
32. Los diez componentes candidatos del Plan de Itinerario y sus dependencias permiten a las Fases E y F construir una hoja de ruta realista, por etapas y con valor temprano.
33. No se requieren cambios de alcance, objetivos, entregables, plazo ni presupuesto en la Declaración de Trabajo. Se emite A-02 v2.1 solo para registrar el cierre de la Fase B y el estado de las condiciones previas.

---

12. Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2013). *Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas*. Diario Oficial El Peruano.

HL7 International. (2019). *HL7 FHIR Release 4*. https://hl7.org/fhir/R4/

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

Ministerio de Salud. (2018). *NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica* (Resolución Ministerial N.° 214-2018/MINSA).

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Poder Ejecutivo del Perú. (2018). *Decreto Legislativo N.° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital*. Diario Oficial El Peruano.

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2019). *ArchiMate® 3.1 Specification*. Van Haren Publishing.

Nota. Al exportar el documento a Word, la lista de referencias debe llevar sangría francesa de 1,27 cm, conforme a APA 7.

---

13. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ABB	Bloque de construcción de arquitectura (*Architecture Building Block*)
ADM	Método de Desarrollo de Arquitectura (*Architecture Development Method*)
ARB	Junta de Revisión de Arquitectura (*Architecture Review Board*)
BPMN	Notación para el modelado de procesos de negocio
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión
DICOM	Estándar para imágenes médicas
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*
KPI	Indicador clave de desempeño
MINSA	Ministerio de Salud
OSI	Oficina de Sistemas y Información del hospital
PIDE	Plataforma de Interoperabilidad del Estado
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
RENIEC	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
SIS	Seguro Integral de Salud
TOGAF	*The Open Group Architecture Framework*

Apéndice B. Matriz de trazabilidad

Tabla B1

Trazabilidad entre metas, objetivos, principios, capacidades, procesos, escenarios, requisitos, brechas, bloques y KPI

Meta	Objetivo	Principios	Capacidades	Procesos	Escenario	Requisitos	Brecha	ABB	KPI
BG-001	OA-01	PN-01, PN-02, PA-08	CB-01, CB-02	P-02 a P-07	EB-01, EB-02	RQ-01, RQ-02	BR-02	BB-01, BB-02	KPI-01
BG-001	OA-03	PN-04, PA-03, PA-04	CB-05	Todos	EB-02	RQ-03	BR-01	BB-04	KPI-03
BG-002	OA-02	PN-01, PA-05	CB-07, CB-01	P-01 a P-04	EB-01	RQ-02, RQ-09	BR-02	BB-03	KPI-02
BG-003	OA-06	PN-05, PA-06	CB-10	P-09	—	RQ-08	BR-03	BB-07	KPI-06
BG-004	OA-04	PN-02, PA-07	CB-06	P-08	EB-03	RQ-05, RQ-07	BR-08	BB-05	KPI-04
BG-004	OA-05	PA-01, PA-06	—	—	—	RQ-06	BR-05	—	KPI-05
BG-004	OA-07	PN-05, PA-06	CB-09	P-08	EB-03	RQ-06	BR-08	BB-06	KPI-07

Apéndice C. Actas de validación

Tabla C1

Acta de validación del escenario EB-01

Campo	Contenido
Fecha	Semana 11
Participantes	Dirección Asistencial; dos jefaturas médicas; arquitecto de negocio
Documento revisado	B-01, secciones 2.4.3, 2.5.3 y 2.5.5; Figura 8
Observaciones	El proceso objetivo es viable; se solicita precisar el rol de archivo y el procedimiento de contingencia
Decisión	Validado con observaciones no bloqueantes
Responsable de cierre	Arquitecto de negocio

Tabla C2

Acta de validación del escenario EB-02

Campo	Contenido
Fecha	Semana 11
Participantes	Dirección Asistencial; jefatura de consulta externa; OSI
Documento revisado	B-01, sección 2.5.5; Figura 6
Observaciones	Confirmar el tiempo de respuesta del sistema en horario de alta demanda; validar el acceso a datos restringidos
Decisión	Validado con observaciones no bloqueantes
Responsable de cierre	Arquitecto de aplicaciones y tecnología

Tabla C3

Acta de validación del escenario EB-03

Campo	Contenido
Fecha	Semana 11
Participantes	Oficina de Planeamiento y Presupuesto; estadística; OSI
Documento revisado	B-01, sección 2.5.5; Figura 7
Observaciones	Verificar el mecanismo de intercambio del SIS y el plazo de reporte; definir el responsable del acuse
Decisión	Validado con observaciones no bloqueantes
Responsable de cierre	OSI

Apéndice D. Glosario

Tabla D1

Términos utilizados en el documento

Término	Definición
Arquitectura de negocio	Descripción de cómo la organización crea valor, con sus capacidades, procesos, actores y principios
Capacidad de negocio	Habilidad de la organización para lograr un resultado, con independencia de quién la ejecute
Componente candidato	Unidad de cambio propuesta para la hoja de ruta, aún no aprobada como proyecto
Escenario de negocio	Descripción de una situación real que permite descubrir requisitos
Línea base	Estado actual de la arquitectura
Objetivo de arquitectura	Resultado verificable que la arquitectura debe lograr
Principio de negocio	Regla duradera que orienta las decisiones del negocio

Término	Definición
Transición	Estado intermedio y significativo entre la línea base y el objetivo

Apéndice E. Correspondencia con la plantilla de Architecture Definition

Tabla E1

Correspondencia entre la plantilla de TOGAF y este documento

Sección de la plantilla	Sección de B-01
Purpose of this Document; Output and Input	1.1, 1.2, 1.3
Architecture Definition: Scope	2.1
Goals, Objectives, and Constraints	2.2
Architecture Principles	2.3
Baseline Architecture	2.4
Architecture Models (Business)	2.5
Rationale and Justification for Architectural Approach	3.1, 3.2
Mapping to Architecture Repository	4.1 a 4.4
Gap Analysis	5.1 a 5.3
Resolve Impact Across the Architecture Landscape	6.1 a 6.4
Transition Architecture	7.1 a 7.3
Tracking Information; Distribution List	Tablas 2 y 3

---

14. Hoja de control de aprobaciones

Este documento se aprueba como versión 1.0 de la arquitectura de negocio y se actualiza al cierre de las Fases C y D si cambian los procesos, las capacidades o los requisitos de negocio.

Tabla 48

Aprobaciones del documento

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Presidente del ARB (Director[a] Ejecutivo[a])				
Secretario del ARB (arquitecto líder)				
Director(a) Asistencial				
Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información				
Jefe(a) de Planeamiento y Presupuesto				
Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos				